Plan de contingencia nacional frente a la época lluviosa - fenómeno de El Niño

Ministerio de Salud Pública

Ecuador

Versión 3.0

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Salud Pública

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. MARCO LEGAL 5
3. OBJETIVO 6
4. ALCANCE 6
5. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 6
5.1. Situación de enfermedades relacionadas a la época lluviosa 6
5.1.1. Enfermedades respiratorias agudas graves IRAG, Influenza, COVID-19 y Otros Virus Respiratorios 6
5.1.2. Enfermedades vectoriales 10
5.1.3. Enfermedades transmitidas por agua y alimentos (ETA) 18
5.1.4. Mordedura de serpiente 23
5.1.5. Enfermedades zoonóticas 25
6. ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 26
6.1. Análisis de susceptibilidad a inundaciones de establecimientos de salud 26
6.2. Análisis de susceptibilidad a movimientos en masa 29
7. IMPACTOS EN EL SECTOR SALUD 30
8. PLAN DE ACCIÓN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA 31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Total de casos confirmados y tasas por 100 mil habitantes de dengue por provincia, Ecuador SE 01 a SE 20 del 2026 12
Tabla 2 Casos de dengue – fallecidos Ecuador 2026 por SE 01 a SE 20 13
Tabla 3 Número de casos confirmados de malaria por especie SE 01 a SE 20 de 2026 15
Tabla 4 Total de casos confirmados de leishmaniasis por SE y provincia, Ecuador 2026 SE 01-20 17
Tabla 5 Casos y tasas de incidencia de fiebre tifoidea y paratifoidea (CIE-10: A01.0–A01.4) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026. 18
Tabla 6 Casos y tasas de incidencia de infecciones debidas a salmonella (CIE-10: A02.0–A02.9) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026 19
Tabla 7 Casos y tasas de incidencia de Shigelosis (CIE-10: A03.0–A03.9) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026. 20
Tabla 8 Casos y tasas de incidencia de Otras intoxicaciones alimentarias (CIE-10: A04.0–A04.9) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026. 21
Tabla 9 Casos y tasas de incidencia de Hepatitis A (CIE-10: A15.0–A15.9) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026. 22
Tabla 10 Mordedura de serpiente por provincia de domicilio, Ecuador SE 1 - SE 20, 2026 23
Tabla 11 Número de establecimientos de salud con riesgo por inundaciones del MSP 27
Tabla 12 Hospitales básicos y generales con susceptibilidad alta y moderada a inundaciones 28
Tabla 13 Establecimientos de salud del MSP con susceptibilidad a movimientos en masa 29
Tabla 14 Plan de acción de preparación y respuesta frente a la época lluviosa y el fenómeno de El Niño 31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Notificación de casos IRAG por semana epidemiológica Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20).....7
Figura 2 Distribución territorial de casos IRAG por semana epidemiológica Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20) 7
Figura 3 Porcentaje de circulación de agentes etiológicos en Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20).....8
Figura 4 Distribución de virus respiratorios según grupo de edad y sexo en Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20) 8
Figura 5 Umbrales de severidad de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios, Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20) 9
Figura 6 Umbrales de severidad de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios, Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20) 9
Figura 7 Notificación de casos de dengue (con y sin signos de alarma DSSA, dengue grave DG, dengue con signos de alarma DCSA) Ecuador 2020-2025 11
Figura 8 Tendencia de malaria por semana epidemiológica de los años 2020-2025 y SE 01 a SE 20 del 2026 14
Figura 9 Distribución espacial de la malaria en las Provincias. Ecuador, 2026 por SE 01 a SE 20 16
Figura 10 Total de casos confirmados de leishmaniasis por SE, Ecuador 2020-2026..... 17
Figura 11 Casos notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea (CIE-10: A01.0–A01.4) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026. 18
Figura 12 Casos notificados de infecciones debidas a salmonella (CIE-10: A02.0–A02.9) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026. 19
Figura 13 Casos notificados de Shigelosis (CIE-10: A03.0–A03.9) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026. 20
Figura 14 Casos notificados de Otras intoxicaciones alimentarias (CIE-10: A04.0–A04.9) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026 21
Figura 15 Casos notificados de Hepatitis A (CIE-10: A15.0–A15.9) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026. 22
Figura 16 Casos de mordedura de serpiente, por grupos de edad y sexo, Ecuador SE 1 - SE 20/ 2026 24
Figura 17 Porcentaje de casos de mordedura de serpiente por tipo, Ecuador, SE 01- SE 20, 2026 24
Figura 18 Casos de Mordedura de Serpiente por semana epidemiológica, Ecuador, 2023-2026, SE1-SE20 25
Figura 19 Tendencia de casos de Leptospirosis por semana epidemiológica, Ecuador, 2023-2026, SE1-SE20. 26
Figura 20 Incidencia de Leptospirosis por Provincias SE 1 - 20, Ecuador, 2023-2026 26
Figura 21 Mapa de establecimientos de salud susceptibles a inundaciones del MSP 27
Figura 22 Mapa de establecimientos de salud del MSP con susceptibilidad a movimientos en masa. 29

1. INTRODUCCIÓN

La temporada de lluvias, en nuestro país se desarrolla aproximadamente entre los meses de octubre-noviembre hasta abril-mayo; la intensidad de las precipitaciones estará sujeta al comportamiento del océano y la atmósfera, ocasionando fluctuaciones de lluvia superiores o inferiores a sus valores normales, llegando a presentar situaciones extremas en determinado espacio y tiempo.

El régimen de precipitaciones en condiciones normales depende de las regiones naturales del país (Costa, Sierra, Amazonia e Insular). En la región Costa, el período lluvioso comienza en el mes de diciembre a enero y termina en el mes de mayo, con un máximo de precipitaciones en los meses de febrero hasta abril; siendo por lo general marzo el mes que registra valores mayores de precipitación. La época seca inicia en el mes de mayo y finaliza en el mes de septiembre.

En la región Sierra, el período lluvioso inicia en el mes de octubre y finaliza en el mes de mayo, con dos valores máximos de precipitaciones, en los meses de marzo a abril, y de octubre a noviembre respectivamente.

En la región de la Amazonía el período lluvioso empieza en febrero y termina en julio aproximadamente. Y la región insular tiene su período lluvioso de diciembre a mayo.

El impacto de la época lluviosa se evidencia en varios sectores del país, pues afecta aspectos como: infraestructura, servicios básicos, comunicaciones, vías, agricultura, ganadería, económico, entre otros.

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un evento climático de variabilidad natural que altera los patrones atmosféricos y oceánicos a nivel global. En el contexto de Ecuador, este fenómeno se manifiesta principalmente a través del calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico Oriental, frente a las costas del país. Esta alteración rompe el equilibrio climático habitual, desencadenando un incremento severo de las precipitaciones, principalmente en la región Costa y en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes.

A lo largo de la historia, la ocurrencia de El Niño en el territorio ecuatoriano ha demostrado tener un carácter multidimensional, afectando gravemente los sistemas sociales, económicos y de infraestructura. La combinación de intensas lluvias, inundaciones fluviales, movimientos en masa y el aumento de la temperatura ambiental genera un escenario de alta vulnerabilidad. Estos eventos no solo impactan la agricultura, la vialidad y el acceso a servicios básicos, sino que también configuran un serio desafío para la salud pública, al propiciar las condiciones idóneas para el incremento de enfermedades vectoriales, de transmisión por agua y de origen alimentario.

Por lo tanto, comprender la dinámica territorial de El Niño en el Ecuador es un requisito indispensable para la gestión integral del riesgo de desastres. La identificación de zonas susceptibles y la implementación de planes de contingencia basados en perfiles epidemiológicos y territoriales resultan cruciales. Solo mediante un enfoque preventivo y multisectorial es posible mitigar los impactos de estas amenazas hidroclimatológicas, garantizando la resiliencia de las comunidades y la continuidad de los servicios esenciales del Estado.

2. MARCO LEGAL

Constitución de la República

La Constitución de la República del Ecuador manda que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir (Art. 32). Así mismo establece que el Estado garantizará el acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud siguiendo principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. De manera similar el art. 358 determina que el sistema nacional de salud implementará, entre otros, los principios de interculturalidad, enfoque de género y generacional.

Adicionalmente, el artículo 389, establece que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres y la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.

Ley Orgánica de Salud

La Ley Orgánica de Salud dispone que la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN) será el Ministerio de Salud Pública (art 4) y ejercerá la rectoría y la responsabilidad de aplicación, control y vigilancia. La ASN deberá determinar las zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria (art. 6). El acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud está garantizado. La ASN elaborará las normas, protocolos y procedimientos de cumplimiento obligatorio para la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes de notificación obligatoria. (Art. 62).

Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres

La Ley dispone en el artículo 12 que los preparativos para la respuesta ante emergencias y desastres se refieren al conjunto de medidas y acciones planificadas y tomadas con anticipación para asegurar una respuesta eficaz ante escenarios de impacto. En el numeral 1 indica que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán coordinar con las instituciones del gobierno central para realizar acciones conjuntas de preparación y fortalecimiento de capacidades para la respuesta en su ámbito territorial.

Reglamento Sanitario Internacional

El RSI aprobado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud en el 2005 por medio de la resolución WHA58.3,1 constituye el marco jurídico que, entre otros aspectos, define las capacidades nacionales básicas, incluso en los puntos de entrada, para el manejo de los eventos agudos de salud pública de importancia potencial o real a escala tanto nacional como internacional, así como los procedimientos administrativos conexos. El RSI (2005) tiene como propósito y alcance prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de

salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias en el tráfico y el comercio internacional.

3. OBJETIVO

Fortalecer la capacidad de preparación y respuesta oportuna del Ministerio de Salud Pública ante los efectos negativos del fenómeno de El Niño y la época lluviosa en el Ecuador, a través de la implementación de la vigilancia epidemiológica activa, la continuidad de los servicios de salud, acciones de promoción de la salud, de infraestructura sanitaria, entre otras, con el fin de proteger la vida y reducir el impacto de salud en la población.

4. ALCANCE

El presente Plan de Contingencia Nacional es de carácter permanente y vigencia indeterminada, por lo que no cuenta con una fecha de caducidad. Su aplicación temporal es de naturaleza dinámica y se regirá bajo los siguientes criterios:

- Vigencia operativa: el plan se mantendrá activo y en ejecución continua durante todos los periodos anuales de época lluviosa en el territorio ecuatoriano, así como durante el desarrollo, evolución y etapas de post-evento de cualquier ciclo del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

- Activación por umbrales de alerta: la fase de respuesta contemplada en este documento se activará de manera inmediata ante las declaratorias oficiales de alerta (amarilla, naranja o roja) emitidas por el ente rector de la gestión de riesgos en el Ecuador.

5. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

5.1. Situación de enfermedades relacionadas a la época lluviosa

El monitoreo de indicadores de salud nos permite identificar aquellos aspectos relevantes que podrían verse afectados por la época lluviosa. Estos incluyen enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la malaria, el zika y la leishmaniasis, así como enfermedades respiratorias agudas, enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades relacionadas con el suministro de agua y enfermedades zoonóticas, como la leptospirosis.

Desde la semana epidemiológica uno, se observa una tendencia al alza en el número de casos de estas enfermedades en comparación con años de referencia anteriores en el país. A continuación, se mencionan algunas que podrían agravarse debido a la época lluviosa.

5.1.1. Enfermedades respiratorias agudas graves IRAG, Influenza, COVID-19 y Otros Virus Respiratorios

- **INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG)**

La dinámica de las enfermedades de notificación obligatoria muestra una estrecha relación con los factores climáticos estacionales, observándose un incremento esperado en el canal endémico debido al aumento de las precipitaciones y la humedad acumulada en el territorio. La intensificación de la época lluviosa condiciona patrones específicos de circulación viral y la proliferación de vectores biológicos. Este escenario epidemiológico se caracteriza por una transición en la dominancia de agentes patógenos que elevan la demanda de atención tanto en la Red Pública Integral de Salud como en la red complementaria.

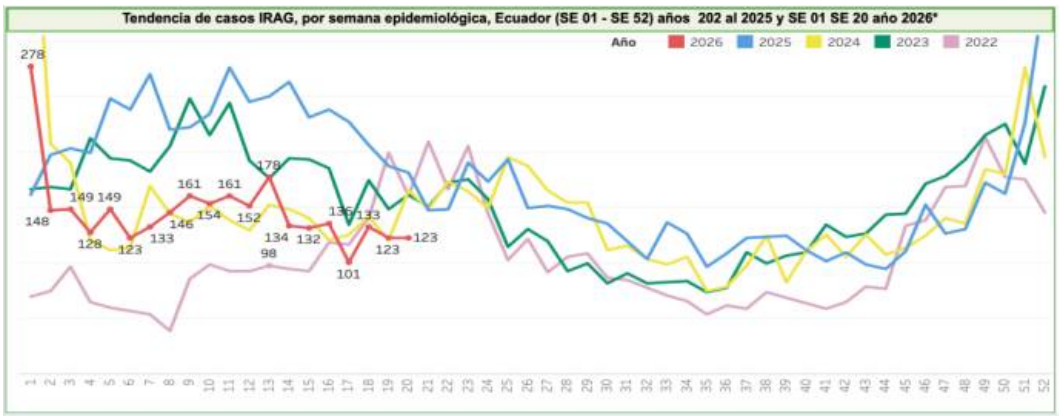


Figura 1 Notificación de casos IRAG por semana epidemiológica Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20)
Fuente: Reporte del Sistema Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves IRAG
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

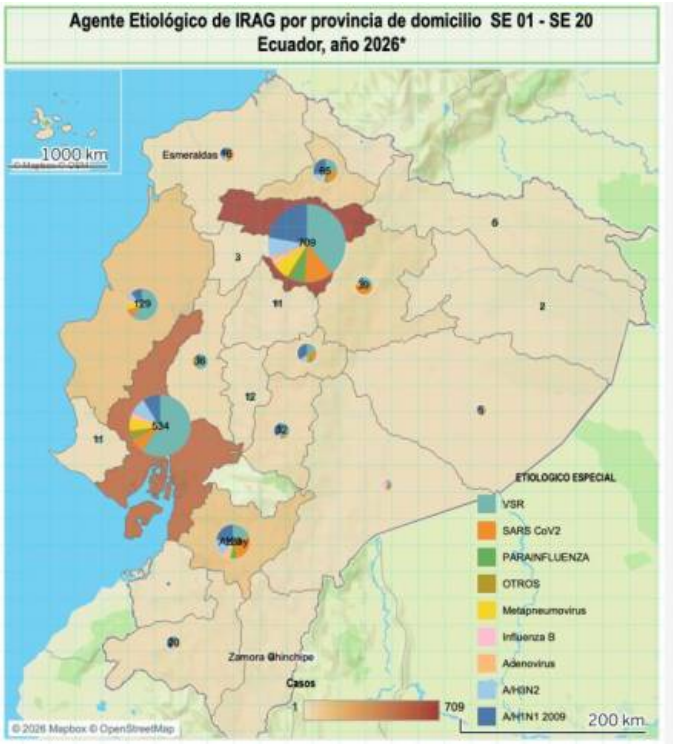


Figura 2 Distribución territorial de casos IRAG por semana epidemiológica Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20)
Fuente: Reporte del Sistema Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves IRAG
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Geográficamente, la mayor concentración de aislamientos virales y reportes de síndromes febriles agudos se localiza en las provincias de la región Costa, con especial incidencia en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, así como en zonas específicas de la Amazonía como Morona Santiago y Pastaza, donde las condiciones demográficas y climáticas aceleran la transmisibilidad.

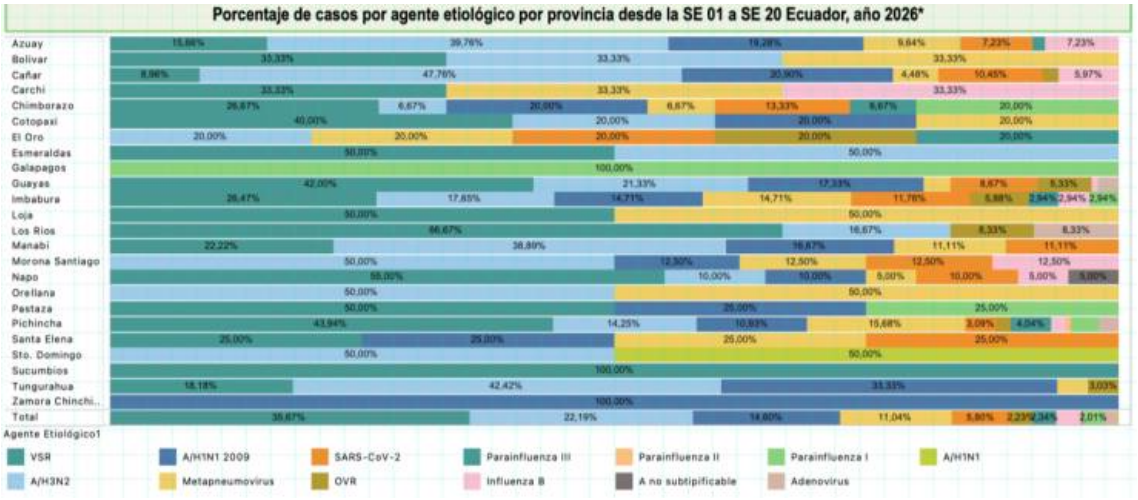


Figura 3 Porcentaje de circulación de agentes etiológicos en Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20)
Fuente: Reporte del Sistema Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves IRAG
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

En el componente de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se confirma una co-circulación activa de Influenza A, con predominio de los subtipos A(H1N1) pdm09 con el (14.60%) y A(H3N2) con el (22.19%), junto al VSR (36,7%) el Metapneumovirus con el (11,04%)y casos esporádicos de SARS-CoV-2 con el (5,80%)

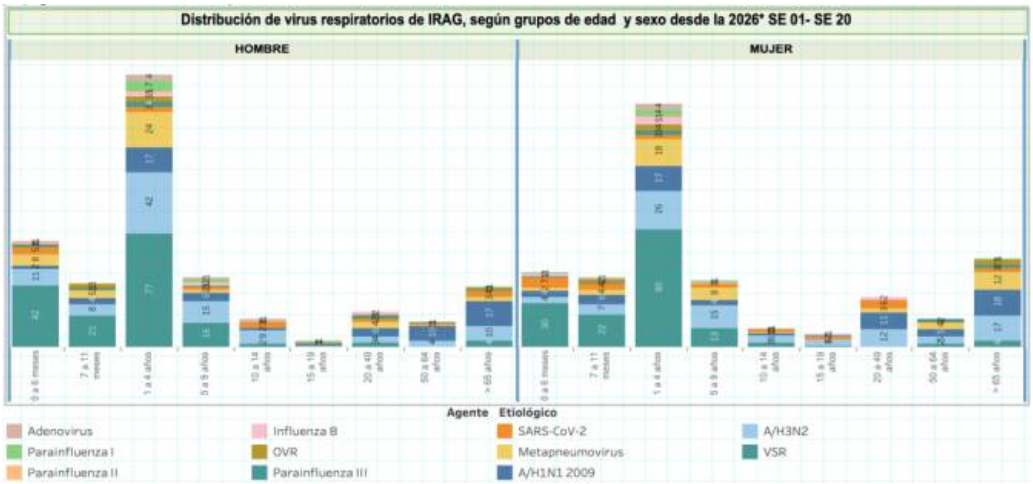


Figura 4 Distribución de virus respiratorios según grupo de edad y sexo en Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20)
Fuente: Reporte del Sistema Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves IRAG
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El impacto clínico identifica a los menores de 5 años (particularmente lactantes menores de un año) y a los adultos mayores de 65 años como los grupos etarios con mayor vulnerabilidad, registrando las tasas más altas de hospitalización por complicaciones pulmonares o necesidad de ventilación mecánica.

- **COVID-19**

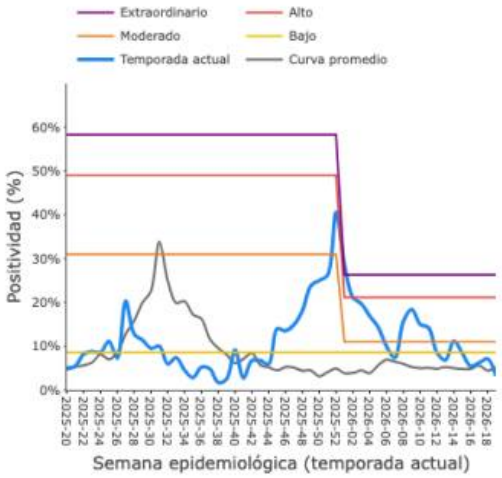


Figura 5 Umbrales de severidad de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios, Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20)
Fuente: Reporte del Sistema Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves IRAG
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La temporada actual (línea azul) experimentó su fase de mayor severidad a finales de 2025, alcanzando un pico de positividad del 40% en la SE 52, situándose firmemente en el umbral alto (línea roja). Al ingresar al año 2026, coincidiendo con el reajuste estacional de los umbrales epidemiológicos, la curva inició un descenso progresivo. Durante las primeras semanas del año (SE 02 a SE 04), la positividad se mantuvo fluctuando en el umbral moderado (alrededor del 20%). No obstante, entre las SE 08 y SE 10, se constató un repunte epidémico bien definido que elevó la positividad hasta un 18%, rompiendo nuevamente la barrera del umbral moderado. Posterior a la SE 12, la curva muestra una tendencia sostenida a la baja, ubicándose en las semanas más recientes (SE 18 y SE 19) por debajo del umbral de alerta estacional, con valores inferiores al 5%, lo que sitúa al país en un escenario de transmisión basal/baja, aunque discretamente por encima de la curva promedio histórica (línea gris).

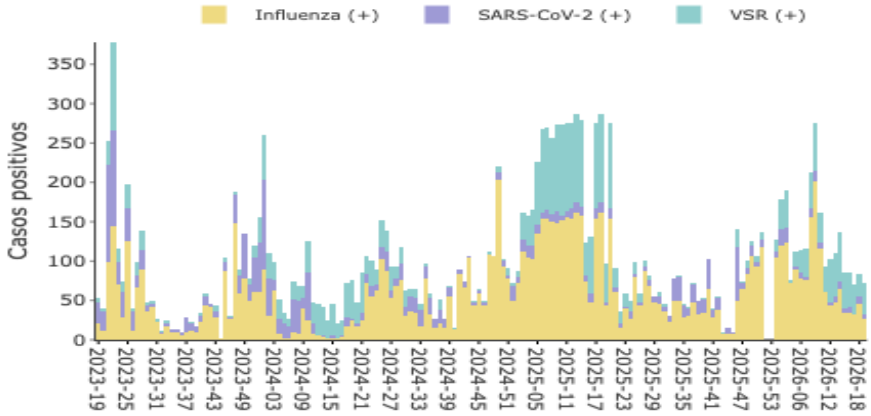


Figura 6 Umbrales de severidad de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios, Ecuador 2022-2026 (SE 01 - SE 20)
Fuente: Reporte del Sistema Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves IRAG
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La caracterización etiológica multianual (periodo 2023 a 2026) confirma que el SARS-CoV-2 (+) ha transitado de un patrón de picos de una dinámica de endemicidad con fluctuaciones de baja intensidad.

Al observar el comportamiento histórico, los brotes más severos de COVID-19 se registraron a mediados de 2023 (SE 25) y a finales de ese mismo año (SE 49-51), donde los casos positivos por este virus representaban una fracción crítica del total de aislamientos respiratorios. Durante el año 2025, el protagonismo de la carga de enfermedad fue asumido mayoritariamente por Influenza y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

En el transcurso del año 2026, la circulación de SARS-CoV-2 se ha mantenido activa pero atenuada, sin evidenciar picos epidémicos aislados de COVID-19. Su presencia se manifiesta principalmente bajo la modalidad de co-circulación secundaria junto a los demás virus respiratorios.

El mayor volumen de positividad para SARS-CoV-2 en el primer trimestre de 2026 se concentró entre las SE 06 y SE 10, actuando como un factor multiplicador de la curva general que, sumado al incremento estacional de Influenza y la reactivación del VSR, generó el repunte de hospitalizaciones registrado en ese periodo.

Hacia las semanas SE 14 a SE 19, la detección de SARS-CoV-2 es marginal, confirmando que la actual temporada lluviosa está siendo dirigida predominantemente por Influenza y VSR, manteniendo al COVID-19 en niveles de control epidemiológico.

5.1.2. Enfermedades vectoriales

- **DENGUE**

En Ecuador contamos con zonas tropicales y subtropicales en las que el dengue es endémico. Esta condición hace que la enfermedad sea una preocupación constante para las autoridades de salud y la población en general en estas zonas e implica una carga significativa para los sistemas de salud, así como un impacto socioeconómico negativo en las comunidades afectadas.

A partir de la semana uno del año 2020 hasta el 2023 se ha registrado una estabilización de casos, sin embargo, desde el 2024 y 2025 se tuvo un aumento en los casos a nivel nacional, mismos que superan el número de casos en años anteriores.

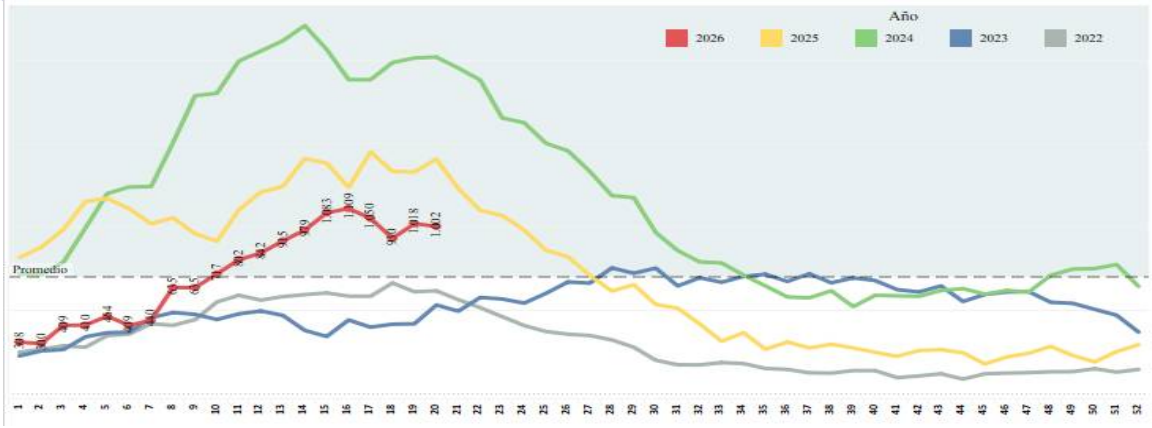


Figura 7 Notificación de casos de dengue (con y sin signos de alarma DSSA, dengue grave DG, dengue con signos de alarma DCSA) Ecuador 2020-2025
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) del Ministerio de Salud Pública, enfermedades transmitidas por vectores, corte SE 01 SE 52 2020-2025.
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Estado actual: Es la línea más corta porque solo registra los datos del año en curso (Semanas Epidemiológicas 01 a 20 del 2026.

Tendencia: Comenzó la semana 1 con 308 casos y ha mostrado un incremento sostenido y alarmante, alcanzando su pico en la semana 16 con 1,109 casos.

Situación de alerta: Desde la semana 10, la curva del 2026 superó la línea de "Promedio" histórico y se encuentra muy por encima de los registros de los años 2022 y 2023 para este mismo periodo, aunque se mantiene por debajo del año crítico (2024). En las últimas semanas de registro (semanas 17 a 20) parece estar fluctuando en una meseta alta (alrededor de los 1,000 casos semanales). El año más crítico de la gráfica: Presenta un brote epidémico masivo y sin precedentes en comparación con el resto de los años.

Comportamiento: Tuvo una escalada vertical y rapidísima en el primer semestre del año, alcanzando el pico más alto de toda la gráfica alrededor de las semanas 14-16. Luego bajó progresivamente hacia la segunda mitad del año.

Año 2025 (Línea Amarilla)

Comportamiento intermedio-alto: Aunque no llegó a los niveles extremos del 2024, se mantuvo durante las primeras 25 semanas del año muy por encima del promedio histórico y de los años anteriores. Registró un pico bimodal (dos curvas altas) entre las semanas 14 y 20 antes de descender drásticamente a niveles muy bajos al final del año.

Año 2023 (Línea Azul) y Año 2022 (Línea Gris)

Años de comportamiento "normal" o bajo: Ambas líneas corren por la parte inferior de la gráfica durante los primeros seis meses, manteniéndose casi siempre por debajo de la línea de promedio general. Curiosamente, en la segunda mitad del año (semanas 26 a 52), el año 2023 superó ligeramente la línea promedio, mientras que el 2022 decayó a los niveles más bajos de todo el histórico.

Conclusiones

Estacionalidad clara: Prácticamente todos los años muestran que el periodo de mayor transmisión y aumento de casos ocurre en el primer semestre del año (entre las semanas 10 y 22, coincidiendo habitualmente con la época invernal/lluviosa en Ecuador).

Alerta epidemiológica para el 2026: El año 2026 está mostrando un comportamiento preocupante. Aunque no ha alcanzado los niveles catastróficos de la epidemia de 2024, está notablemente peor que el promedio histórico y sigue un patrón muy similar de elevación al que tuvo el año 2025.

Tabla 1 Total de casos confirmados y tasas por 100 mil habitantes de dengue por provincia, Ecuador SE 01 a SE 20 del 2026

	Casos		tasa por provincia por 100mil H		Casos	tasa por provincia por 100mil H
Inf. Provincia	SE 01-19	SE 20	SE 01-19	SE 20	Total	Total
GALAPAGOS	52	47	11	24	99	15
BOLIVAR	116	17	6	8	133	6
MORONA SANTIAGO	181	6	5	7	187	5
CHIMBORAZO	64	9	2	10	73	2
ZAMORA CHINCHIPE	23		5		23	5
COTOPAXI	251	26	2	3	277	2
CAÑAR	136	8	2	2	144	2
LOJA	78	20	2	3	98	2
AZUAY	147	19	1	2	166	2
SUCUMBIOS	192	11	2	2	203	2
NAPO	345	18	2	2	363	2
ORELLANA	292	6	2	1	298	2
PASTAZA	73	2	1	1	75	1
ESMERALDAS	476	27	1	1	503	1
LOS RIOS	2.088	137	1	1	2.225	1
SANTA ELENA	620	48	1	1	668	1
MANABI	3.200	263	1	1	3.463	1
EL ORO	560	36	1	1	596	1
CARCHI	1		1		1	1
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	700	62	1	1	762	1
IMBABURA	31		1		31	1
TUNGURAHUA	7	1	0	0	8	0
GUAYAS	3.719	238	0	0	3.957	0
PICHINCHA	98	3	0	0	101	0
Total general	13.450	1.004	0	1	14.454	0

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) del Ministerio de Salud Pública, enfermedades transmitidas por vectores, corte año 2026 SE 01-20.
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La tabla mide el comportamiento del dengue combinando dos indicadores epidemiológicos clave: frecuencia absoluta (número de casos) y frecuencia relativa (tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes).

Periodos: Compara el acumulado de las primeras diecinueve semanas (SE 01-19) con los datos específicos de la última semana reportada (SE 20), cerrando con el Total consolidado.

Criterio de ordenamiento: La tabla no está ordenada por el volumen total de enfermos, sino de manera descendente por la tasa de incidencia total por provincia. Esta metodología ayuda a identificar dónde el impacto poblacional es genuinamente más severo.

Si miramos la tendencia de los últimos años, queda claro que el dengue en Ecuador tiene un "reloj" muy marcado: siempre explota en los primeros seis meses del año, coincidiendo con las lluvias y el calor.

El problema es que el 2026 está siendo un año complicado. Aunque afortunadamente no se ha llegado a los niveles catastróficos del 2024 (que fue un año histórico de contagios), la curva actual está muy por encima de lo que se considera "normal" o promedio. Llevamos semanas estancados en una meseta alta, registrando alrededor de 1,000 casos nuevos cada semana, esto genera una alerta máxima.

Tabla 2 Casos de dengue – fallecidos Ecuador 2026 por SE 01 a SE 20

	Con discapacidad	Muerto	Vivo	Total
A90X Dengue sin complicaciones			12.344	12.344
A91X Dengue con signos de alarma	1	3	1.982	1.986
A91X Dengue grave		11	113	124
Total	1	14	14.439	14.454

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Hasta la SE 20 del 2026 se registraron un total de 14 defunciones por dengue, de las 14,454 personas que se han enfermado de dengue la situación se interpreta:

Los casos leves DSSA: Casi 9 de cada 10 personas (**el 85.4%**) pasaron por el "dengue sin complicaciones". Tuvieron fiebre, dolor de cuerpo y malestar, pero se recuperaron en casa sin que su vida corriera peligro.

Las señales de alerta DCSA: Unas 1,986 personas tuvieron que ir al hospital porque su cuerpo empezó a dar señales de alarma (dolores de estómago muy fuertes, vómitos que no paran o sangrados). Aquí es donde los médicos tienen que actuar rápido para que la cosa no pase a mayores.

El dengue grave (La zona crítica): Solo un grupo muy pequeño, el 0.9% (124 personas), llegó a la peor etapa de la enfermedad, donde el virus ataca con todo y pone los órganos en riesgo.

- **MALARIA**

La malaria es una enfermedad producida por la picadura de algunas especies de mosquitos hembras de *Anopheles*, infectados con los parásitos *Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae* y *Plasmodium ovale.*

En Ecuador existen zonas tropicales y subtropicales donde la malaria existe. Las condiciones climáticas de esas zonas hacen que la enfermedad sea una preocupación constante para las autoridades de salud y la población en general.

En el último informe mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre el paludismo, publicado en diciembre 2021, en la región de las Américas los casos de malaria se redujeron en un 60% (de 1,5 millones a 0,60 millones) y la incidencia de casos en un 70% (de 14 a 4) entre 2000 y 2021. Las muertes por malaria se redujeron en un 64% (de 919 a 334) y la tasa de mortalidad en un 73% (de 0,8 a 0,2)

En Ecuador las infecciones por: *Plasmodium vivax* y *Plasmodium falciparum* son las más comunes, siendo este último el que más complicaciones o muertes produce. En el año 2023 se han notificado 690 casos asociados en su mayoría a *Plasmodium vivax.*

En la SE 20 del año 2026 se han notificado 71 casos confirmados de malaria; de los cuales los 68 casos asociados a *Plasmodium vivax.*

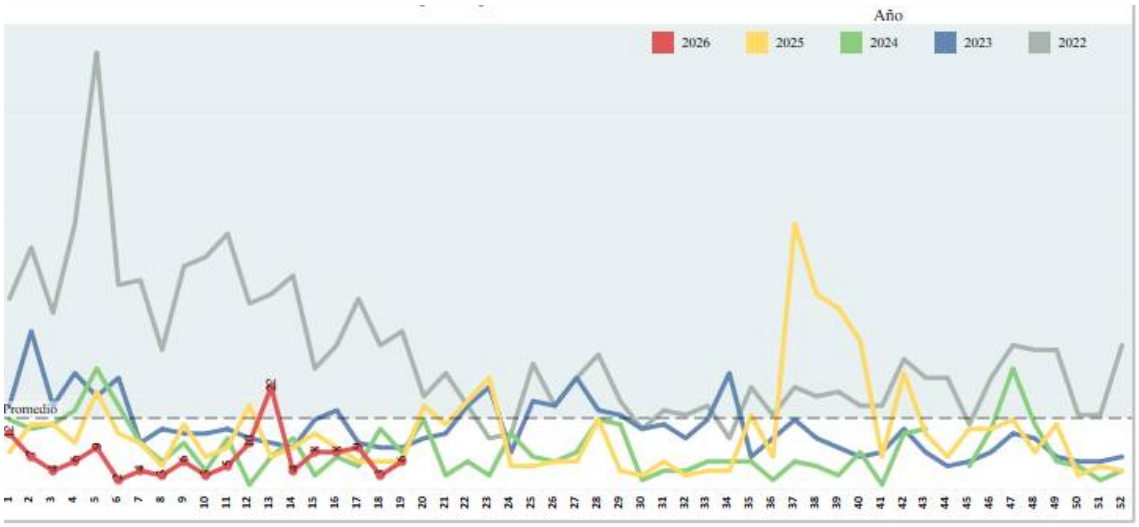


Figura 8 Tendencia de malaria por semana epidemiológica de los años 2020-2025 y SE 01 a SE 20 del 2026
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública enfermedades transmitidas por vectores, Corte hasta SE 01 al 20 de 2026
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

A diferencia del dengue, que sube y baja de forma suave y predecible con las estaciones, la malaria se muestra en la gráfica como una línea llena de "picos y valles" muy abruptos. Esto pasa porque la malaria no ataca a todo el país al mismo tiempo, sino que explota en brotes muy específicos y aislados (por ejemplo, en comunidades rurales, selváticas o zonas de minerías).

Lo realmente positivo es la evolución de los últimos años:

El pasado crítico (2022): Fue, por lejos, el año más difícil. La gráfica muestra picos altísimos de contagios durante los primeros meses.

El susto del año pasado (2025): El año transcurrió muy tranquilo, pero tuvo un brote sorpresivo y violento a finales de año (entre las semanas 37 y 40) que disparó las alarmas.

El panorama actual (2026): Estamos en el mejor escenario de los últimos 5 años. Durante las 19 semanas reportadas, la línea roja se ha mantenido casi todo el tiempo en la "zona de éxito" (por debajo del promedio histórico), registrando apenas entre 3 y 9 casos por semana.

El único momento de tensión en lo que va del 2026 ocurrió en la semana 13, cuando los casos saltaron repentinamente a 22.

Este pico confirma la naturaleza "traicionera" de la malaria: basta con que una persona infectada llegue a una comunidad vulnerable para que los casos se multipliquen en

cuestión de días. Afortunadamente, las autoridades lograron contenerlo rápido, y en las semanas siguientes los números volvieron a caer a sus niveles mínimos.

En resumen: las estrategias contra la malaria están funcionando muy bien en el país, pero la vigilancia no se puede descuidar.

Tabla 3 Número de casos confirmados de malaria por especie SE 01 a SE 20 de 2026

	B500 Malaria no complicada por Plasmodium Falciparum	B500-B509 Malaria complicada por Plasmodium Falciparum	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax	Total
ASTAZA			89	89
MORONA SANTIAGO		1	30	31
SUCUMBIOS			3	3
LOS RIOS		1	1	2
ESMERALDAS	1		1	2
ORELLANA			1	1
IMBABURA			1	1
GUAYAS			1	1
EL ORO	1			1
Total general	2	2	127	131

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Enfermedades transmitidas por vectores, corte hasta SE01-20 de 2025
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Basado en el archivo figura N° 3, se presenta a continuación el análisis epidemiológico de la tabla, la cual detalla los casos de malaria clasificados por provincia, por la especie de parásito causante (*Plasmodium vivax* vs. *Plasmodium falciparum*) y por la severidad clínica del cuadro.

Epidemiológicamente, la distribución del tipo de parásito es el dato más valioso de la tabla, ya que el riesgo biológico cambia drásticamente según la especie:

***Plasmodium vivax* (B519 - Malaria no complicada):** Es la especie absolutamente dominante en el territorio nacional, acumulando **127 de los 131 casos totales (96.9%)**. Aunque causa cuadros febriles intensos y puede reactivarse a lo largo del tiempo debido a sus formas latentes en el hígado (hipnozoítos), por lo general se clasifica como "no complicada" y tiene una tasa de mortalidad muy baja.

***Plasmodium falciparum* (B500 / B500-B509):** Registra apenas **4 casos en total (3.1%)**. Sin embargo, esta especie es el foco rojo para la vigilancia epidemiológica, ya que es la única capaz de evolucionar rápidamente hacia formas letales (como la malaria cerebral o falla multiorgánica).

Al cruzar los datos de las columnas se observa una excelente noticia desde el punto de vista de salud pública: la enorme mayoría de los casos son manejables.

Casos No Complicados: Sumando *P. vivax* (127) y *P. falciparum* no complicado (2), da un total de **129 casos (98.5%)** que se resolvieron o manejan de forma ambulatoria o con tratamiento estándar.

Casos Complicados (B500-B509): Solo se registran **2 casos de malaria complicada por *Plasmodium falciparum*** en todo el reporte (1.5% del total). Estos pacientes representan emergencias médicas reales que requieren hospitalización inmediata.

La malaria en Ecuador no es uniforme; la tabla demuestra que está fuertemente concentrada en la **región Amazónica**:

Pastaza (El foco principal): Lidera a nivel nacional con 89 casos, todos ellos causados por *Plasmodium vivax*. Concentra el 67.9% de toda la carga de malaria del reporte, lo que la convierte en la zona prioritaria para la distribución de mosquiteros e intervenciones de control ambiental. Morona Santiago: Es el segundo foco de importancia con 31 casos. Lo preocupante aquí es que, además de sus 30 casos de *P. vivax*, registra 1 de los 2 únicos casos de malaria complicada (*P. falciparum*) del país.Los Ríos: Aunque solo registra 2 casos en total, enciente alertas epidemiológicas locales porque uno de ellos es el segundo caso de malaria complicada por *P. falciparum*.Esmeraldas y El Oro: Son las únicas provincias que registran casos de *Plasmodium falciparum* en su forma no complicada (1 caso cada una). Zonas con casos aislados: Sucumbíos (3), Orellana (1), Imbabura (1) y Guayas (1) muestran cifras mínimas, sugiriendo casos importados o transmisiones muy esporádicas.

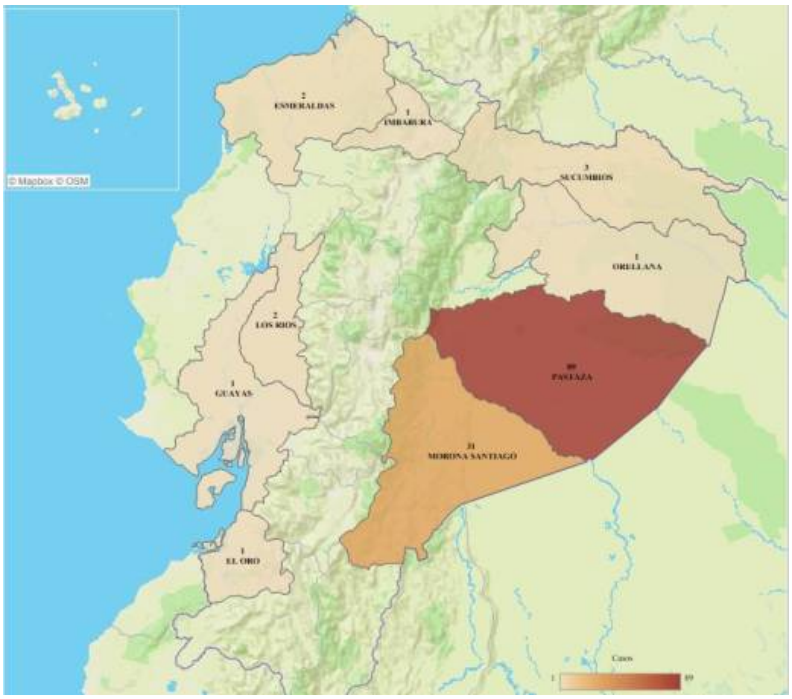


Figura 9 Distribución espacial de la malaria en las Provincias. Ecuador, 2026 por SE 01 a SE 20
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (Corte hasta SE 20)
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

- **LEISHMANIASIS**

Se registra un pico atípico y masivo de **162 casos** que rompe totalmente la tendencia histórica. Epidemiológicamente, esto suele responder a una acumulación de datos o cierre extemporáneo del sistema de información al finalizar el año anterior, más que a un brote real en esos siete días.

Tendencia Actual (Semanas 2 a 19 de 2026): Tras el pico inicial, la línea roja desciende de forma abrupta y se estabiliza muy por debajo de la media histórica (línea de promedio). En las últimas semanas graficadas (15 a 19), los casos se mantienen en niveles mínimos (entre 1 y 4 casos), ubicándose en una zona de seguridad ó éxito.

Comparativa Histórica: El año 2025 (línea amarilla) representó un periodo de alta transmisión, manteniéndose casi todo el año por encima del promedio y con picos importantes hacia el último trimestre. En contraste, los años 2022, 2023 y 2024 muestran un comportamiento endémico estable y cíclico alrededor de la media.

Conclusión: Excluyendo el sesgo de la semana 1, el escenario de la leishmaniasis para 2026 muestra un comportamiento controlado y a la baja en comparación con los cuatro años anteriores.

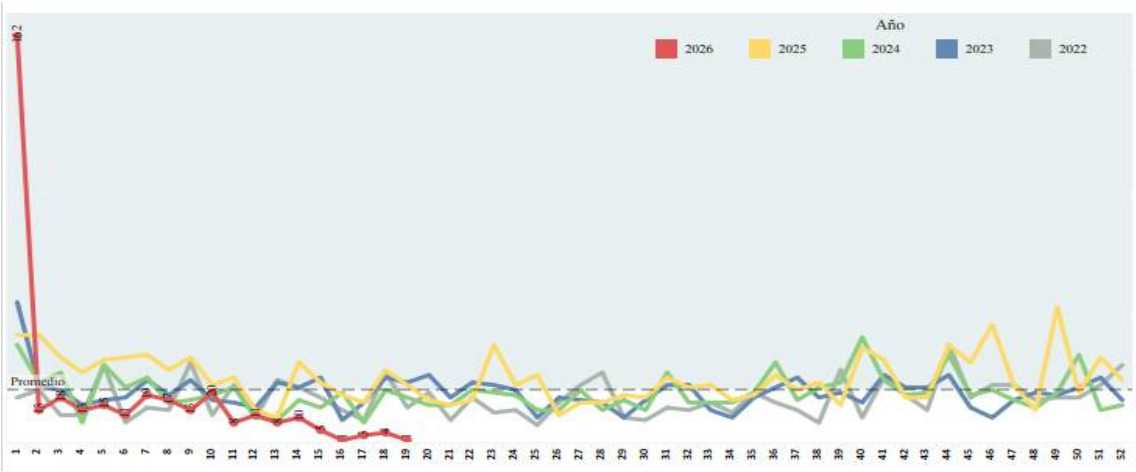


Figura 10 Total de casos confirmados de leishmaniasis por SE, Ecuador 2020-2026
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, enfermedades transmitidas por vectores, corte SE 20 de 2026
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Tabla 4 Total de casos confirmados de leishmaniasis por SE y provincia, Ecuador 2026 SE 01-20

	B552 Leishmaniasis mucocutánea	B551 Leishmaniasis Cutánea	Total
PICHINCHA		76	76
MORONA SANTIAGO		69	69
ESMERALDAS		44	44
ZAMORA CHINCHIPE		27	27
SANTO DOMINGO D..		26	26
ORELLANA	1	17	18
SUCUMBIOS	1	16	17
PASTAZA		17	17
MANABI		11	11
LOS RIOS		8	8
NAPO	2	5	7
CHIMBORAZO		5	5
IMBABURA		4	4
COTOPAXI		4	4
GUAYAS		3	3
BOLIVAR		3	3
AZUAY		2	2
TUNGURAHUA		1	1
LOJA		1	1
EL ORO		1	1
CAÑAR		1	1
Total general	4	341	345

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, enfermedades transmitidas por vectores, Corte 2026 SE 01-20
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

5.1.3. Enfermedades transmitidas por agua y alimentos (ETA)

- **FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA**

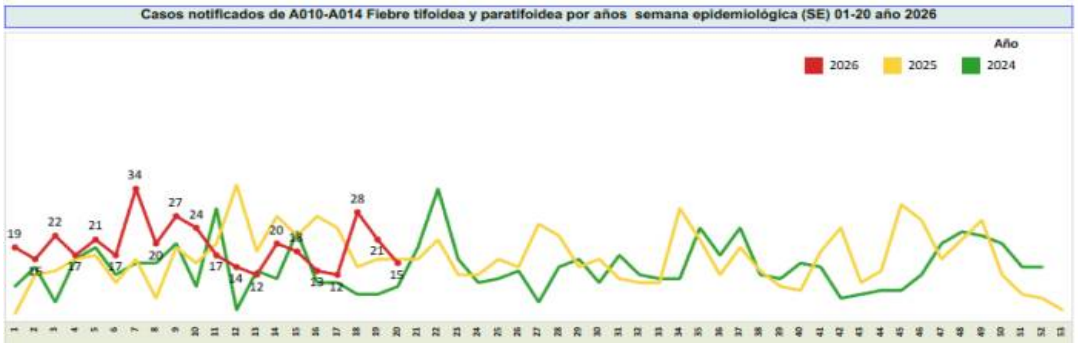


Figura 11 Casos notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea (CIE-10: A01.0–A01.4) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026.
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Al contrastar y comparar las primeras 20 semanas de cada año (2024,2025,2026), se evidencia que 2026 supera de forma sistemática y desproporcionada la carga de los años previos. En 2024 el comportamiento fue estable y bajo, mientras que el 2025 mostró un incremento moderado. El pico (SE 6 hasta la SE 8) de 2026 representa un aumento de casos respecto al año anterior. Las primeras 20 semanas de 2026 han sido de mayor riesgo e impacto epidemiológico por fiebre tifoidea de los últimos tres años, fuertemente condicionado por la emergencia climática, además coincide directamente con los meses de mayores precipitaciones lo que exige mantener activas las medidas de control e intervenciones en agua y saneamiento.

Tabla 5 Casos y tasas de incidencia de fiebre tifoidea y paratifoidea (CIE-10: A01.0–A01.4) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026.

Casos de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026

	Casos		Tasa provincia por..		Casos	Tasa pr..
PROVIN..	SE 01-19 2026	SE 20 2026	SE 01-19 2026	SE 20 2026	Total	Total
SUCUMBIOS	53	1	24,15	0,46	54	24,61
ORELLANA	17		9,29		17	9,29
CAÑAR	17	1	5,87	0,35	18	6,22
MORONA SAN..	11	1	4,66	0,42	12	5,08
NAPO	6	1	4,24	0,71	7	4,94
ESMERALDAS	28		4,45		28	4,45
PASTAZA	5		4,02		5	4,02
COTOPAXI	16	1	3,37	0,21	17	3,58
GUAYAS	137	9	2,94	0,19	146	3,14
LOS RIOS	27		2,64		27	2,64
TUNGURAHUA	8		1,37		8	1,37
CARCHI	2		1,18		2	1,18
LOJA	5	1	0,98	0,20	6	1,17
CHIMBORAZO	5		0,98		5	0,98
AZUAY	6		0,71		6	0,71
IMBABURA	3		0,62		3	0,62
EL ORO	4		0,52		4	0,52
BOLIVAR	1		0,46		1	0,46
PICHINCHA	13		0,43		13	0,43
SANTO DOMIN..	2		0,36		2	0,36
MANABI	5		0,30		5	0,30
SANTA ELENA	1		0,24		1	0,24
Total	372	15	2,10	0,23	387	2,18

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Desde la SE 1 hasta la SE 20 de 2026, Ecuador registra 387 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea, con una tasa nacional de 2.18 por cada 100,000 habitantes. El análisis revela un escenario con doble prioridad nacional. En el caso de la Provincia de Guayas, esta representa el epicentro de la carga absoluta del país con el 37.7% de los casos (146), mientras que la región amazónica, liderada por la Provincia de Sucumbíos, presenta el mayor riesgo relativo con una tasa crítica de 24.61 casos por 100,000 habitantes. El riesgo de contraer tifoidea en Sucumbíos, en cuanto al cálculo de la razón de tasas de incidencia, se establece en 11,28 veces mayor que el promedio nacional.

- **INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA**

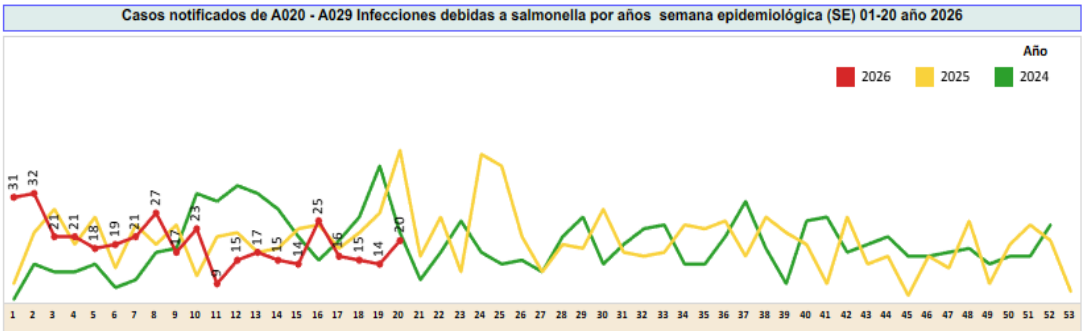


Figura 12 Casos notificados de infecciones debidas a salmonella (CIE-10: A02.0–A02.9) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026.
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

El análisis comparativo de las semanas epidemiológica desde la 01 a la 20 indica que las infecciones por Salmonella en 2026 presentaron un comportamiento atípico de inicio explosivo, registrando sus picos más altos en la SE 01 con 31 casos y SE 02 con 32 casos, lo cual superó drásticamente los datos registrados en los años 2024 y 2025, respectivamente. El brote inicial también se relaciona con eventos climáticos, como la presencia de inundaciones.

Tabla 6 Casos y tasas de incidencia de infecciones debidas a salmonella (CIE-10: A02.0–A02.9) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026

Casos de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026

	Casos		Tasa provincia ..		Casos	Tasa ..
PROVIN..	SE 01-19 2026	SE 20 2026	SE 01-19 2026	SE 20 2026	Total	Total
NAPO	29	1	20,49	0,71	30	21,19
PASTAZA	20	1	16,08	0,80	21	16,89
SUCUMBIOS	29		13,21		29	13,21
COTOPAXI	27	1	5,69	0,21	28	5,90
CAÑAR	17		5,87		17	5,87
MORONA SAN..	12		5,08		12	5,08
EL ORO	22	2	2,88	0,26	24	3,14
GUAYAS	121	8	2,60	0,17	129	2,77
ORELLANA	4	1	2,19	0,55	5	2,73
CHIMBORAZO	9		1,76		9	1,76
BOLIVAR	3		1,38		3	1,38
PICHINCHA	40	1	1,31	0,03	41	1,35
CARCHI	2		1,18		2	1,18
MANABI	17	2	1,02	0,12	19	1,14
ZAMORA CHIN..	1		0,82		1	0,82
ESMERALDAS	4	1	0,64	0,16	5	0,79
TUNGURAHUA	4		0,69		4	0,69
LOJA	3		0,59		3	0,59
AZUAY	2	1	0,24	0,12	3	0,36
LOS RIOS	2	1	0,20	0,10	3	0,29
IMBABURA	1		0,21		1	0,21
SANTO DOMIN..	1		0,18		1	0,18
Total	370	20	2,12	0,15	390	2,24

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Desde la SE 1 hasta la SE 20 de 2026, Ecuador registra 390 casos de infecciones por Salmonella, registrando una tasa de incidencia nacional de 2.24 por cada 100,000 habitantes. El análisis determina que la provincia del Guayas concentra la mayor carga del evento con 129 casos. Sin embargo, las provincias de la Amazonía como Napo, Pastaza y Sucumbíos, lideran las tasas de incidencia. No obstante, el riesgo epidemiológico se concentra principalmente en Napo, donde el cálculo de razón de tasa de incidencia, determina que en esta Provincia el riesgo de contraer Salmonella es 9.45 veces más alto que el promedio nacional.

- **SHIGELOSIS**

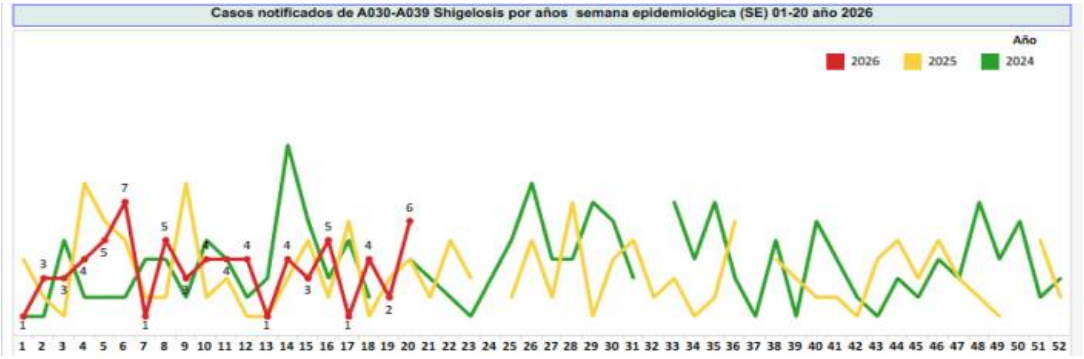


Figura 13 Casos notificados de Shigelosis (CIE-10: A03.0–A03.9) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026.
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

El análisis de la SE01 a la SE20 indica que la shigelosis en 2026 mantiene un comportamiento similar con los rangos históricos de los años 2024 y 2025, respectivamente. Su pico máximo corresponde a la SE 6 con 7 casos notificados. La persistencia de casos se relaciona con la facilidad que posee el patógeno, para su propagación, considerando que es altamente infeccioso.

Tabla 7 Casos y tasas de incidencia de shigelosis (CIE-10: A03.0–A03.9) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026.

Casos de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026

	Casos		Tasa provincia p..		Casos	Tasa p..
	SE 01-19	SE 20	SE 01-19	SE 20		
PROVIN..	2026	2026	2026	2026	Total	Total
PASTAZA	5		4,02		5	4,02
ORELLANA	2	1	1,09	0,55	3	1,64
MORONA SAN..	3		1,27		3	1,27
CHIMBORAZO	6		1,18		6	1,18
TUNGURAHUA	5		0,86		5	0,86
PICHINCHA	22	4	0,72	0,13	26	0,85
COTOPAXI	4		0,84		4	0,84
NAPO	1		0,71		1	0,71
CARCHI		1		0,59	1	0,59
EL ORO	2		0,26		2	0,26
MANABI	3		0,18		3	0,18
SANTO DOMIN..	1		0,18		1	0,18
GUAYAS	8		0,17		8	0,17
ESMERALDAS	1		0,16		1	0,16
AZUAY	1		0,12		1	0,12
Total	64	6	0,44	0,18	70	0,48

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Desde la SE1 hasta la SE 20 de 2026, Ecuador registra 70 casos de shigelosis, con una tasa de incidencia nacional de 0.48 casos por cada 100,000 habitantes. El análisis indica que la Provincia de Pichincha concentra el mayor volumen de casos con 26 notificaciones. No obstante, el riesgo epidemiológico se establece en la Provincia de Pastaza, cuyo cálculo de la razón de tasas de incidencia, establece que en este lugar existe un riesgo 8.37 veces mayor de contraer shigelosis, en comparación con el promedio nacional.

- **OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS**



Figura 14 Casos notificados de Otras intoxicaciones alimentarias (CIE-10: A04.0–A04.9) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Desde la SE01 hasta la SE20 se evidencia que los casos de Otras Intoxicaciones Alimentarias Bacterianas en 2026 se encuentran por encima de los datos históricos registrados en los años 2024 y 2025, respectivamente. La transmisión de la enfermedad en las primeras semanas del año, SE2 con 278 casos y la SE4 con 283 notificaciones, representan los principales picos, a su vez este evento consolida el mayor impacto epidemiológico de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, con una alta carga de la enfermedad en el país.

Tabla 8 Casos y tasas de incidencia de Otras intoxicaciones alimentarias (CIE-10: A04.0–A04.9) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026.

Casos de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026

	Casos		Tasa provincia ..		Casos	Tasa ..
PROVINCIA	SE 01-19 2026	SE 20 2026	SE 01-19 2026	SE 20 2026	Total	Total
CARCHI	250	8	147,51	4,72	258	152,23
PASTAZA	163	4	131,06	3,22	167	134,28
CHIMBORAZO	394	26	77,17	5,09	420	82,26
PICHINCHA	2.006	113	65,86	3,71	2.119	69,57
MORONA SANTIAGO	118	13	49,99	5,51	131	55,50
COTOPAXI	217	10	45,74	2,11	227	47,85
NAPO	36	1	25,43	0,71	37	26,14
ORELLANA	31	1	16,95	0,55	32	17,49
TUNGURAHUA	90	5	15,45	0,86	95	16,31
ZAMORA CHINCHIPE	19		15,63		19	15,63
AZUAY	94	5	11,14	0,59	99	11,74
LOJA	57	2	11,13	0,39	59	11,52
IMBABURA	51	4	10,61	0,83	55	11,44
EL ORO	83	3	10,86	0,39	86	11,26
LOS RIOS	111	1	10,87	0,10	112	10,96
ESMERALDAS	53	9	8,42	1,43	62	9,85
GUAYAS	363	25	7,80	0,54	388	8,33
CAÑAR	16	1	5,53	0,35	17	5,87
SANTO DOMINGO	33		5,87		33	5,87
SANTA ELENA	19	3	4,54	0,72	22	5,26
GALAPAGOS	1		3,62		1	3,62
MANABI	55	4	3,31	0,24	59	3,55
SUCUMBIOS	3		1,37		3	1,37
BOLIVAR	2		0,92		2	0,92
Total	4.265	238	23,84	1,42	4.503	25,17

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Desde la SE1 hasta la SE 20 de 2026, Ecuador registra un total de 4,503 casos de Otras Intoxicaciones Alimentarias Bacterianas, con una tasa de incidencia nacional de 25.17 casos por cada 100,000 habitantes. El análisis indica que la Provincia de Pichincha concentra la mayor cantidad de casos del país, con un total de 2,119 notificaciones. Sin embargo, el riesgo epidemiológico se concentra en las Provincias del Carchi y Pastaza, y de acuerdo al cálculo de razón de tasas de incidencia, se establece que en Carchi existe un riesgo 6.05 veces mayor de presentar una intoxicación alimentaria bacteriana y que Pastaza presenta 5.33 veces mayor riesgo de enfermar por el mismo evento, en comparación con el promedio nacional, respectivamente.

- **HEPATITIS A**

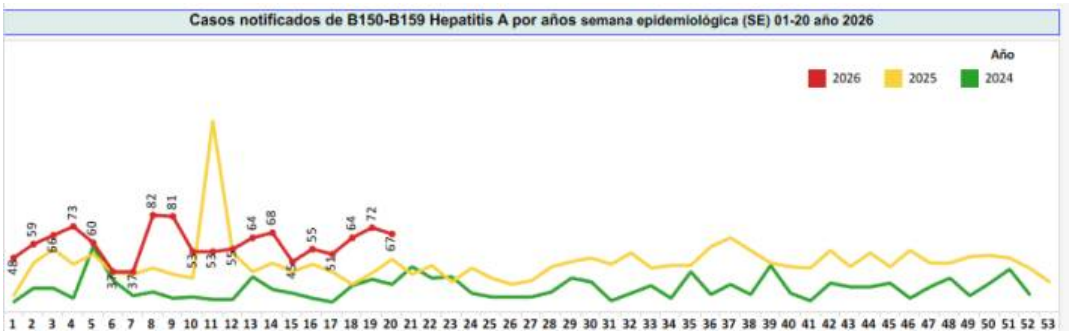


Figura 15 Casos notificados de Hepatitis A (CIE-10: A15.0–A15.9) por semanas epidemiológicas. Ecuador, años 2024 - 2025 y acumulado desde la SE 1 hasta la SE 20 del año 2026.
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Desde la SE01 hasta la SE20 se evidencia que, en Ecuador, la Hepatitis A en 2026 se encuentra por encima de los datos históricos registrados en los años 2024 y 2025, respectivamente. Este evento demuestra una alta endemicidad en el país, con transmisión persistente.

Tabla 9 Casos y tasas de incidencia de Hepatitis A (CIE-10: A15.0–A15.9) por provincias y semanas epidemiológicas (SE) 01 a 20, Ecuador, 2026.

Casos de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026

	Casos		Tasa provinci..		Casos	Tasa ..
	SE 01-19	SE 20	SE 01-19	SE 20	Total	Total
PROVINCIA	2026	2026	2026	2026		
NAPO	141	2	99,60	1,41	143	101,02
MORONA SANTIAGO	67	2	28,38	0,85	69	29,23
ORELLANA	44	2	24,06	1,09	46	25,15
CHIMBORAZO	123	2	24,09	0,39	125	24,48
TUNGURAHUA	125	6	21,46	1,03	131	22,49
ZAMORA CHINCHIPE	23	1	18,93	0,82	24	19,75
COTOPAXI	91	2	19,18	0,42	93	19,60
PASTAZA	14	2	11,26	1,61	16	12,86
SUCUMBIOS	26	1	11,85	0,46	27	12,30
AZUAY	55	18	6,52	2,13	73	8,65
PICHINCHA	218	19	7,16	0,62	237	7,78
BOLIVAR	16		7,35		16	7,35
LOJA	33		6,44		33	6,44
ESMERALDAS	27		4,29		27	4,29
IMBABURA	10	1	2,08	0,21	11	2,29
SANTO DOMINGO	12		2,13		12	2,13
MANABI	32	1	1,93	0,06	33	1,99
LOS RIOS	13	1	1,27	0,10	14	1,37
GUAYAS	44	7	0,95	0,15	51	1,10
EL ORO	6		0,79		6	0,79
SANTA ELENA	2		0,48		2	0,48
CAÑAR	1		0,35		1	0,35
Total	1.123	67	6,35	0,47	1.190	6,72

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

En el análisis de la SE1 hasta la SE 20 de 2026, Ecuador acumula 1,190 casos de Hepatitis A, con una tasa de incidencia nacional de 6.72 casos por cada 100,000 habitantes. Esto indica que la Provincia de Pichincha concentra la mayor cantidad de casos con un total de 237 notificaciones. Sin embargo, el riesgo epidemiológico se establece en la región de la Amazonía, principalmente en la Provincia de Napo, cuyo cálculo de razón de tasas de incidencia determina que el riesgo de contraer Hepatitis A en esta Provincia es 15.03 veces mayor al promedio nacional.

5.1.4. Mordedura de serpiente

En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima tropical y subtropical.

Hasta la SE 20 del año 2026, se reportan 558 casos de mordedura de serpientes con una tasa de 3.2 (x 100mil hab), la mayor cantidad de casos se registran en la provincia de Morona Santiago con una tasa 43.4 (por 100mil hab).

Tabla 10 Mordedura de serpiente por provincia de domicilio, Ecuador SE 1 - SE 20, 2026

Provincia	Casos		Tasa por provincia		Casos	Tasa provincia (por 100.000 habitantes
	SE 01-19	SE 20	SE 01-19	SE 20	Total	Total
Morona Santiago	91		43.4		91	43.4
Pastaza	37	1	30.6	0.8	38	31.4
Zamora Chinchipe	22	1	18.5	0.8	23	19.3
Napo	23		16.4		23	16.4
Orellana	31	1	15.8	0.5	32	16.3
Sucumbíos	20	1	9.8	0.5	21	10.3
Bolívar	17		8.3		17	8.3
Esmeraldas	35	1	5.8	0.2	36	5.9
St. Domingo Tsáchilas	28	1	5.3	0.2	29	5.5
Los Ríos	53		5.4		53	5.4
Manabí	71	1	4.1	0.1	72	4.2
Loja	19		3.8		19	3.8
Carchi	4		2.3		4	2.3
El Oro	17		2.3		17	2.3
Cotopaxi	9	1	1.8	0.2	10	2.0
Santa Elena	6		1.5		6	1.5
Cañar	2		0.8		2	0.8
Pichincha	23		0.7		23	0.7
Guayas	30	2	0.6	0	32	0.7
Imbabura	3		0.6		3	0.6
Azuay	4		0.5		4	0.5
Chimborazo	1		0.2		1	0.2
Zona no delimitada	2				2	
Total	**548**	**10**	**3.1**	**0.1**	**558**	**3.2**

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, efectos tóxicos, Corte SE 01 - SE 20 de 2026
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

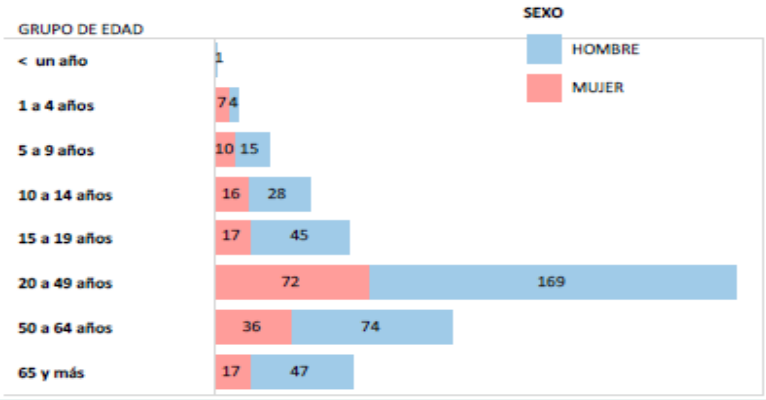


Figura 16 Casos de mordedura de serpiente, por grupos de edad y sexo, Ecuador SE 1 - SE 20/ 2026
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública efectos tóxicos,
Corte: SE 01-SE 20 DE 2026
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Durante el año 2026, el grupo de edad más afectado es de 20-49 años de sexo masculino. Se han reportado 3 casos fallecidos por esta causa hasta el momento. Esto evidencia que las tareas agrícolas que es donde se producen estos accidentes están asignadas en su mayoría al sexo masculino y en edad reproductiva, las mujeres tambien son afectadas en menor número.

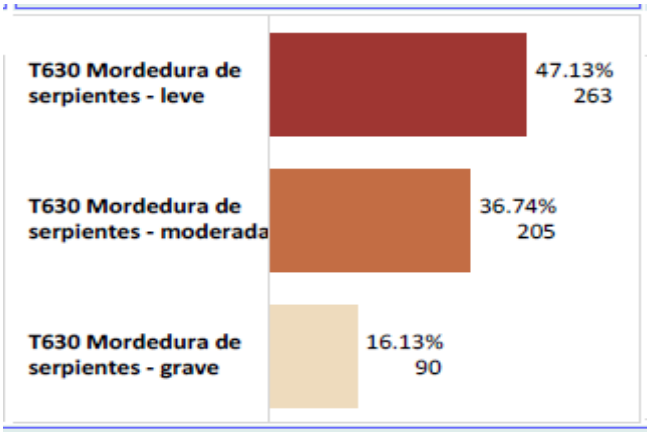


Figura 17 Porcentaje de casos de mordedura de serpiente por tipo, Ecuador, SE 01- SE 20, 2026
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública efectos tóxicos,
Corte: SE 01-SE 20 DE 2026
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Los datos reflejan que el 47.13% de los casos de mordedura de serpiente son leves, sin embargo, entre las mordeduras moderadas y graves suman un total de 52.87%**,** son los que requieren manejo médico de moderado a cuidado intensivo, ejerciendo presión inmediata sobre los recursos hospitalarios.

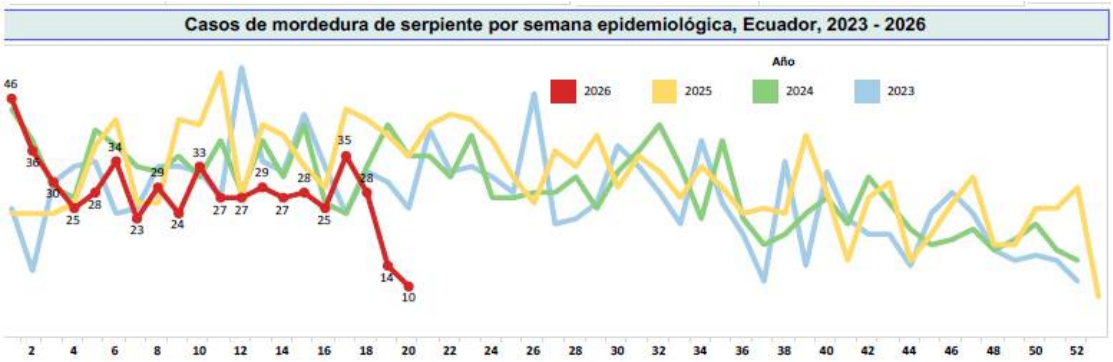


Figura 18 Casos de Mordedura de Serpiente por semana epidemiológica, Ecuador, 2023-2026, SE1-SE20
Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública efectos tóxicos, Corte 2023-2026
Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Se evidencia que existe un incremento del número de casos de mordedura de serpiente en algunas semanas epidemiológicas que coinciden entre varios años; estos picos podrían estar asociados a la temporada invernal, al incremento de las actividades agrícolas y de campo, así como a una mayor interacción entre las personas y los hábitats naturales de las serpientes. Estas condiciones favorecen la exposición de la población al riesgo de accidentes ofídicos, especialmente en zonas rurales y de alta biodiversidad, además que dificulta el ingreso a comunidades rurales distantes de los profesionales de salud o a su vez que la población solicite asistencia médica.

5.1.5. Enfermedades zoonóticas

- **Leptospirosis**

La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del género Leptospira, con más de 300 serovariedades que afectan a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones.

Clínicamente, varía desde un cuadro leve similar a la gripe hasta formas graves como el síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal, ictericia y hemorragias, o la hemorragia pulmonar severa.

En Ecuador, la leptospirosis es de notificación obligatoria debido a su impacto en la salud pública. En 2025, los casos aumentaron respecto a los tres años anteriores.
Para el año 2026 la tendencia es similar al año anterior, sin embargo, no ha tenido un incremento significativo en la semana epidemiológica de la 14 a 20 respecto al año anterior.

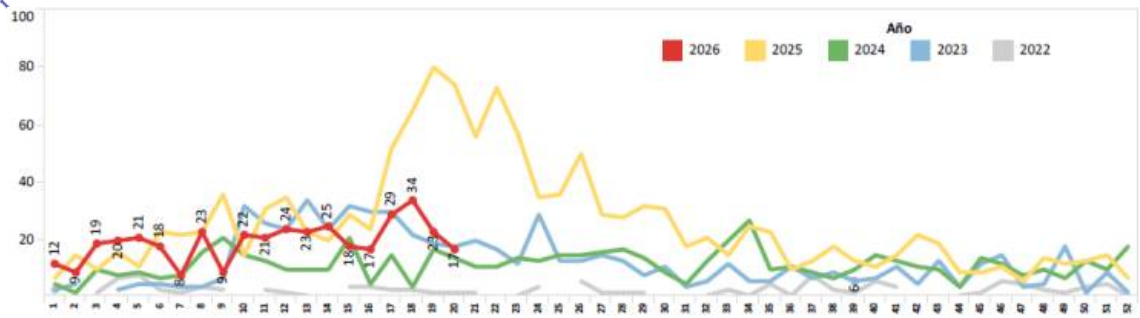


Figura 19 Tendencia de casos de Leptospirosis por semana epidemiológica, Ecuador, 2023-2026, SE1-SE20.
Fuente: Sistema de Información VIEPI SE1 -SE20, 2026.
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La provincia de Guayas registra la mayor cantidad de casos acumulados. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados.

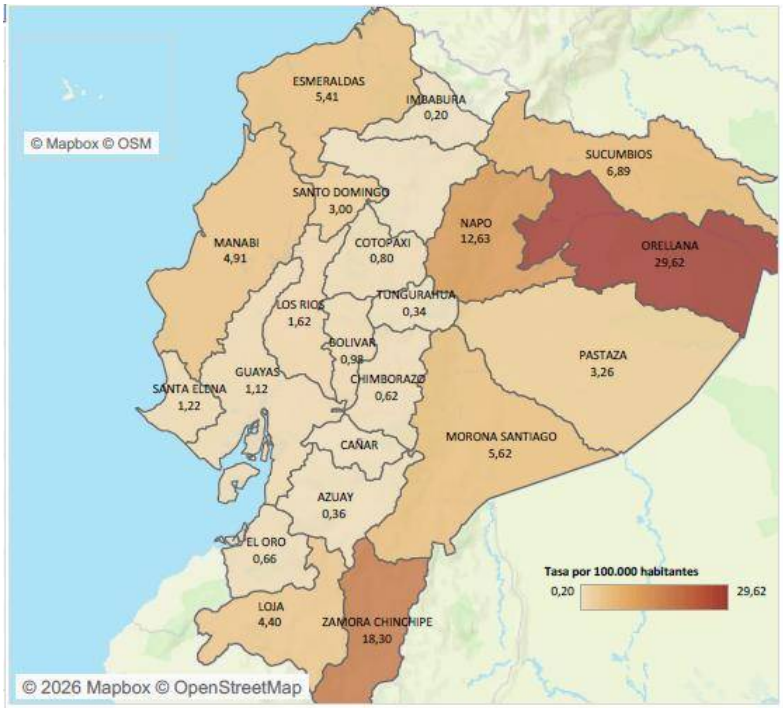


Figura 20 Incidencia de Leptospirosis por Provincias SE 1 - 20, Ecuador, 2023-2026
Fuente: Sistema de Información VIEPI SE1-SE20, 2026
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

6. ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Los principales factores para que se produzcan las inundaciones en el país son:

- Precipitaciones estacionales.
- Fenómeno de El Niño.
- Sobrepasar la capacidad de evacuación de los sistemas de drenaje en urbes.
- Represamiento de ríos.
- Ruptura o desbordamiento de represas y represamientos.

6.1. Análisis de susceptibilidad a inundaciones de establecimientos de salud

Para el cálculo de la susceptibilidad a inundaciones se utilizó la cobertura de zonas de inundación generada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y se delimitó a los 1.500 m.s.n.m, conforme lo estipulado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para el fenómeno de El Niño.

El Ministerio de Salud Pública tiene 359 establecimientos de salud con susceptibilidad a inundaciones, como se muestra a continuación:

Tabla 11 Número de establecimientos de salud con riesgo por inundaciones del MSP

	SUSCEPTIBILIDAD			
TIPOLOGÍA	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**TOTAL**
Centro de salud tipo A	81	77	108	**266**
Centro de salud tipo B	4	9	9	**22**
Centro de salud tipo C	4	5	6	**15**
Centros especializados			1	**1**
Hospital básico	7	5	4	**16**
Hospital general	2	2	1	**5**
Puesto de salud	8	7	19	**34**
TOTAL	**106**	**105**	**148**	**359**

Elaboración por: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Daños

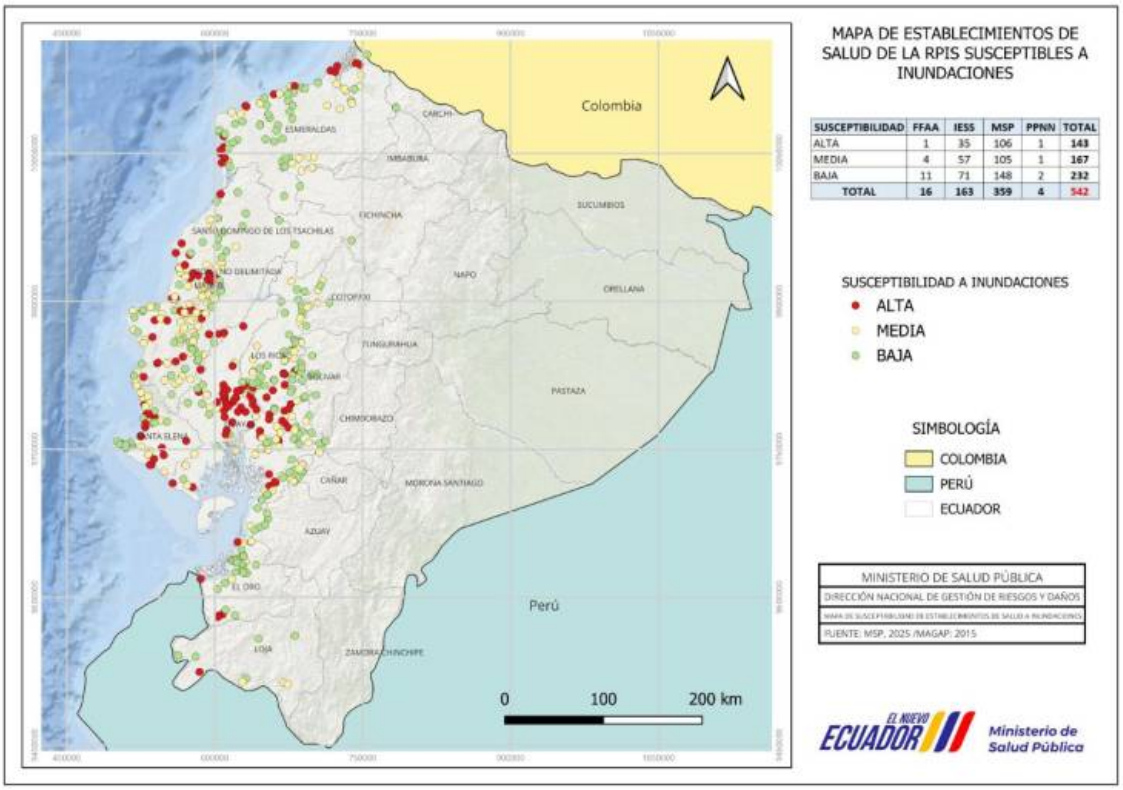


Figura 21 Mapa de establecimientos de salud susceptibles a inundaciones del MSP
Elaboración por: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Daños

El análisis determina que el 93% de establecimientos susceptibles son de primer nivel de atención en salud (centros de salud tipo A, B y C y puestos de salud). De ese 93%, el 4% son centros de salud tipo C de atención de 24 horas con área de emergencia. Para el segundo nivel de atención, se encuentran en susceptibilidad 21 hospitales (9 en susceptibilidad alta, 7 en susceptibilidad media y 5 en susceptibilidad baja).

Tabla 12 Hospitales básicos y generales con susceptibilidad alta y moderada a inundaciones

PROVINCIA	CANTÓN	TIPOLOGÍA	NOMBRE	SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES
Los Ríos	Urdaneta	Hospital Básico	Hospital Básico De Urdaneta - Juan Montalván	Alta
Los Ríos	Ventanas	Hospital Básico	Hospital Básico Jaime Roldós Aguilera	Media
Los Ríos	Vinces	Hospital Básico	Hospital Básico De Vinces - Nicolás Infante	Media
Esmeraldas	Muisne	Hospital Básico	Hospital Básico De Muisne - Carlos Del Pozo	Alta
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Hospital Básico	Hospital Básico De Borbón	Media
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Hospital Básico	Hospital Básico De Limones	Alta
Esmeraldas	San Lorenzo	Hospital Básico	Hospital Básico De San Lorenzo - Divina Providencia	Media
Esmeraldas	Esmeraldas	Hospital General	Hospital General Esmeraldas Sur Delfina Torres De Concha	Media
Manabí	Bolívar	Hospital Básico	Hospital Básico De Calceta - Aníbal Gonzales Álava	Media
Manabí	Sucre	Hospital General	Hospital General Miguel Alcívar	Media
Manabí	Pedernales	Hospital Básico	Hospital Básico De Pedernales Dr. Francisco Vasquez Balda	Alta
Manabí	Chone	Hospital General	Hospital General Napoleón Dávila Córdova	Alta
El Oro	El Guabo	Hospital Básico	Hospital Básico María Lorena Serrano	Baja
Guayas	San Jacinto De Yaguachi	Hospital Básico	Hospital Básico De Yaguachi - José Cevallos Ruiz	Alta
Guayas	Daule	Hospital Básico	Hospital Básico De Daule	Alta
Guayas	Guayaquil	Hospital General	Hospital General Monte Sinaí	Alta
Guayas	Naranjal	Hospital Básico	Hospital Básico De Naranjal	Baja
Santa Elena	Salinas	Hospital Básico	Hospital Básico De La Libertad - Rafael Serrano	Baja
Santa Elena	Salinas	Hospital Básico	Hospital Básico De Salinas - José Garcés Rodríguez	Baja

Santa Elena	Santa Elena	Hospital Básico	Hospital Básico De Manglar Alto	Alta
Santa Elena	Santa Elena	Hospital General	Hospital General Liborio Panchana Sotomayor	Baja

Elaboración por: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Daños

6.2. Análisis de susceptibilidad a movimientos en masa

A continuación, se muestran los establecimientos con susceptibilidad a movimientos en masa: el 10.4% de establecimientos están en categoría de Alta susceptibilidad, el 33.9% con susceptibilidad Moderada, 13.14% con susceptibilidad Mediana y por último un 42.5% en Baja o Nula susceptibilidad.

Tabla 13 Establecimientos de salud del MSP con susceptibilidad a movimientos en masa

	SUSCEPTIBILIDAD				
TIPOLOGÍA	**ALTA**	**MODERADA**	**MEDIANA**	**BAJA A NULA**	**TOTAL**
Puesto de salud	8	36	11	24	**79**
Centro de salud tipo A	18	58	24	74	**174**
Centro de salud tipo B	2	2	1	13	**18**
Centro de salud tipo C			1	8	**9**
Consultorio general		1			**1**
Hospital básico	2	1	1	2	**6**
Hospital general				2	**2**
TOTAL	**30**	**98**	**38**	**123**	**289**

Elaboración por: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Daños

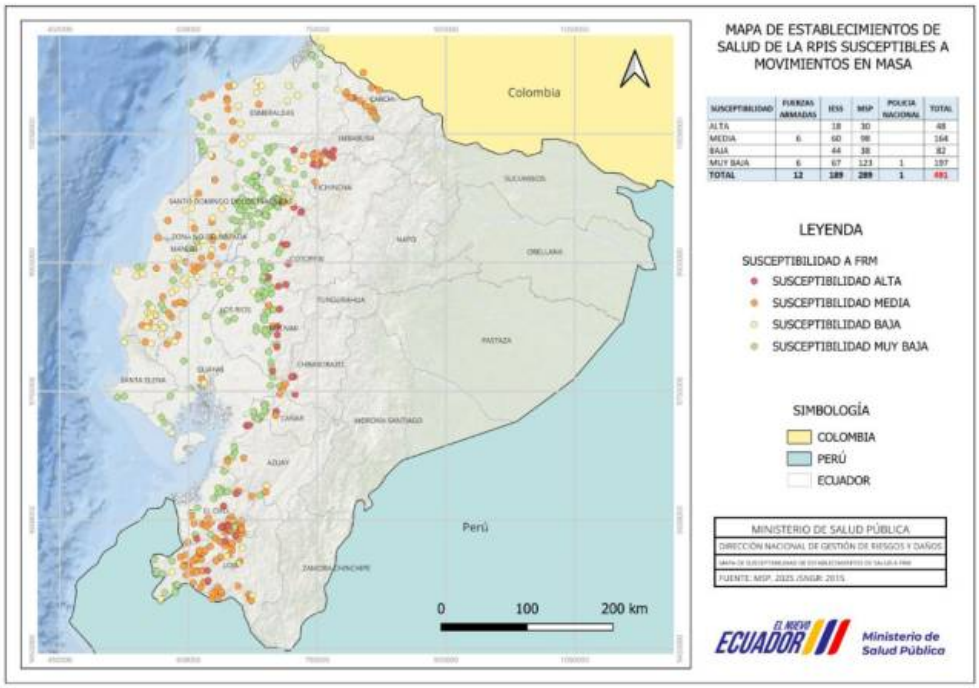


Figura 22 Mapa de establecimientos de salud del MSP con susceptibilidad a movimientos en masa.
Elaboración por: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Daños

7. IMPACTOS EN EL SECTOR SALUD

Afectación grave en la infraestructura de los establecimientos de salud. La infraestructura física de los servicios de salud se ve gravemente afectada por la época lluviosa, que produce daños por inundaciones; deterioro de los equipos y mobiliarios; efectos en techos, paredes, ventanas, materiales e insumos; problemas con los sistemas de desagüe y alcantarillado; suministro y abastecimiento de agua potable, electricidad, gas y combustibles; anegación por lodo; daños en el sistema de alcantarillado, entre otros.

Impactos ambientales. Por el exceso de lluvias los ríos y lagos se han salido de sus riberas causando inundaciones y contaminación del agua potable. Colapso de sistema de drenaje de aguas negras. La recolección y eliminación de la basura no es efectuada en tiempo y forma debido a la destrucción yo anegamiento de carreteras, equipos y otras instalaciones. Desplazamiento de pobladores con animales y pertenencias hacia alojamientos temporales u otra localidad. Afectación de cultivos por la sequía con disminución de agua para consumo, para animales y cultivos. Se incrementa el riesgo de incendios, causando perdida de zonas verdes y provocando contaminación de aire por material particulado.

Transmisión de enfermedades infecciosas. Tras una época lluviosa, el riesgo potencial de las enfermedades transmisibles varía no solo por los cambios que se producen en el ambiente, sino también por los cambios en la densidad de población, los trastornos en el funcionamiento de los servicios públicos y la interrupción de los servicios de salud pública. Cabe señalar, asimismo, que el riesgo de enfermedades transmisibles relacionado con estos cambios climáticos depende del nivel endémico de la enfermedad en la comunidad; por consiguiente, existe poco riesgo de que se produzca una enfermedad dada si el organismo causal no está presente de antemano. Esto pone de relieve la necesidad de contar con un programa eficaz de vigilancia de enfermedades antes de que surja la época lluviosa, para enfermedades vectoriales, enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas por el agua y/o alimentos contaminados, enfermedades dérmicas y de mucosa, enfermedades respiratorias, infecciones del sistema nervioso y trastornos y problemas de salud mental.

Alto riesgo de deterioro de las condiciones de salud mental de la población afectada. Los problemas de salud mental fueron causados directamente por la experiencia de estar en una inundación o indirectamente durante el proceso de reconstrucción. Las sequías han tenido impacto negativo en la salud mental de las poblaciones de comunidades rurales cuyas vidas, generalmente, dependen de las lluvias. Las intervenciones esenciales para enfrentar estos efectos son alertas tempranas y los sistemas de vigilancia además de la identificación de grupos vulnerables, regiones y sectores con mayor riesgo de los efectos de la sequía, para poder planificar la intervención en salud mental y apoyo psicosocial.

Acciones de vigilancia epidemiológica, atención oportuna de casos en todos los niveles de atención y control vectorial. El mantenimiento de los sistemas de notificación de las enfermedades bajo vigilancia, monitoreo e incorporación de las patologías infectocontagiosas sospechosas de emerger con potencialidad epidémica en el territorio con posterioridad al evento, implementación de las medidas para el control de vectores, actualización de los mapas y control de criaderos e identificación de focos y brotes epidémicos para su atención oportuna.

Impulso a la comunicación en crisis y las acciones de promoción y prevención en salud, en poblaciones y nacionalidades indígenas. Por las características culturales y socioeconómicas, la población indígena tiene una participación limitada en las estrategias de respuesta frente a cualquier evento; en este contexto, la comunicación en crisis, las acciones de educomunicación y de promoción en salud, con pertinencia cultural, resultan fundamentales, en el marco del plan nacional de comunicación.

8. PLAN DE ACCIÓN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA

El plan de contingencia basa su accionar en las prioridades establecidas por el gobierno nacional en materia de salud pública, se plantea de la siguiente forma:

Tabla 14 Plan de acción de preparación y respuesta frente a la época lluviosa y el fenómeno de El Niño

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
Fortalecimiento de las capacidades diagnóstico - terapéuticas	- Capacitar en diagnóstico y tratamiento de enfermedades propias de la época lluviosa al personal de primer y segundo nivel de atención para reducir la mortalidad asociada a deficiencias en la preparación del personal sanitario. - Disponer de un equipo técnico - asesor de enfermedades emergentes por la época lluviosa que pueda orientar a acciones clínicas que permitan mejorar la toma de decisiones en casos complejos o atípicos	Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos	- Monitorear el abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos en salud en los establecimientos de salud y direcciones provinciales. - Abastecer de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud a las direcciones provinciales y establecimientos de salud.	Dirección Nacional de Abastecimiento de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Otros Insumos Estratégicos en Salud
Capacidad técnica de los laboratorios y centros de referencia	- Capacitar al personal de laboratorio sobre la identificación adecuada de los vectores causantes de arbovirosis y otros patógenos de interés en salud pública. - Fortalecer el flujograma de manejo de la red de laboratorios, para que los procesamientos de muestras que requieran ser derivadas a laboratorios de mayor complejidad	Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica Dirección Nacional de Hospitales
Prevención y manejo integrado de vectores	- Intensificar la educación familiar y comunitaria para la eliminación de reservorios y criaderos de mosquitos, que incluye la contratación personal para realizar las actividades de destrucción de criaderos y actividades educomunicacionales directas con la comunidad y familias.	Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control para Enfermedades transmisibles

	- Implementar estrategias educomunicacionales para reducir las conductas de riesgo en la población, orientadas en la reducción de criaderos y la prevención de la automedicación. - Ejecutar mingas comunitarias en articulación con los municipios y GADS, para mejorar las condiciones medioambientales, peridomiciliarias, comunitarias. - Aumentar las coberturas de control de fase larvaria a las zonas receptivas y con riesgo de importación de arbovirus y otras enfermedades transmitidas por vectores. - Intensificar medidas de manejo integrado de vectores en situación de brotes con las medidas de protección medioambiental, incluye la contratación de personal, máquinas y equipos de control vectorial y equipos de protección personal.	
Vigilancia epidemiológica	- Monitorear la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores (dengue, malaria, fiebre amarilla), enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas y enfermedades zoonóticas. - Reforzar con capacitaciones de la notificación obligatoria para los casos sospechosos o confirmados de enfermedades relacionadas con la época lluviosa. - Analizar regularmente los datos recopilados para identificar tendencias y patrones epidemiológicos. - Intensificar la vigilancia en los puntos de entrada al país (puertos, aeropuertos, fronteras) para detectar y controlar la propagación de enfermedades importadas relacionadas con la época lluviosa. - Proporcionar capacitación regular al personal de salud y de las instituciones cooperantes en detección temprana, manejo de casos, prevención y control de enfermedades relacionadas con la época lluviosa, que incluye brindar información actualizada sobre los signos y síntomas específicos a los cuales deben estar atentos, así como las medidas preventivas y de control más efectivas.	Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Mantenimiento de infraestructuras de salud	- Identificar las zonas vulnerables a inundaciones o movimientos en masa dentro y alrededor del establecimiento de salud. - El establecimiento de Salud desarrollará el plan de contingencia	Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria

	para evacuar o proteger a los pacientes, el personal y los equipos médicos. - El personal técnico realizará el recorrido general de verificación visual de la edificación donde detecte posibles áreas o sistemas de ingeniería que podría ser afectadas (sumideros de pisos, terrazas, losas, canaletas, bajantes de agua lluvia, rejillas, etc.) que no obstaculicen la evacuación de agua - Verificar las posibles filtraciones de agua, para corregir inmediatamente. - Verificar mampostería y corregir si existen grietas o deficiencia en recubrimientos. - Verificar la estabilidad de muros, columnas. - Proteger el ingreso de aguas lluvias por juntas de dilatación. - Identificar posibles puntos de ingreso por desbordamiento de agua lluvia, colocar barreras artificiales temporales, con el criterio de no obstaculizar salidas de evacuación del personal y usuarios del establecimiento de salud. - Revisar el suministro de agua potable y energía eléctrica, para evitar cortes o contaminaciones que afecten el normal desenvolvimiento del establecimiento de salud. - Verificar el estado del suministro de gases medicinales, sistema de calefacción, ventilación y aires acondicionado, el suministro de gas licuado.	
Prestación de Servicios – continuidad de los servicios de salud en establecimientos de primer nivel de atención	- Coordinar con el área encargada del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos para la dotación de antibióticos de amplio espectro, sales de rehidratación oral, antipalúdicos, analgésicos y sueros antiofídicos, repelentes con DEET, toldos impregnados de insecticida de larga duración y kits de higiene para evitar enfermedades dermatológicas; además de pruebas rápidas para dengue y malaria en centros de salud tipo A y B. - Identificar los lugares contingentes de establecimientos de salud expuestos a inundaciones. - Identificar la nominal de Equipos de Atención Integral de Salud disponibles por micro-red provincial, estableciendo roles de guardia y relevos para evitar el agotamiento del personal. - Identificar comunidades con probabilidad de aislamiento para programar calendarios de visita de	Dirección Nacional de Atención Integral en Salud

	brigadas móviles antes de que la conectividad se pierda, para la entrega de medicación continua suficiente para 90 días a pacientes con enfermedades crónicas principalmente: diabetes e hipertensión. - Realizar el censo de mujeres embarazadas en el tercer trimestre, adultos mayores con movilidad reducida y personas con discapacidad en zonas de susceptibilidad a inundaciones. - Verificar los termos de transporte, cajas térmicas y paquetes de frío. - Validar "Sitios de Resguardo de Vacunas" en zonas seguras de la provincia con respaldo eléctrico garantizado. - Implementar un sistema de triage de desastres o clasificación rápida en exteriores del centro de salud tipo C para separar pacientes urgentes de aquellos con patologías leves que pueden ser derivados a unidades móviles. - Realizar la reconversión de áreas no asistenciales como salas de espera o áreas administrativas para convertirlas en zonas de observación o hidratación. Uso de carpas si la estructura interna está comprometida. - Obligatoriedad del reporte diario, en lugar de semanal, de los síndromes definidos como prioritarios: febriles con sospecha de dengue/malaria, diarreicos (EDA), ictéricos (leptospirosis) y respiratorios. - Desplegar personal de salud en los alojamientos para brindar atención integral en salud a la población albergada. - Activar brigadas de laboratorio para la recolección y transporte de muestras in situ en medios de transporte alternativos (lanchas o aéreos) hacia los centros de referencia provincial. - Reaperturar inmediatamente de los centros de salud de la red provincial. Si la estructura está inhabilitada, se deben habilitar unidades móviles o espacios comunales para no interrumpir el flujo de pacientes crónicos con énfasis en hipertensión, diabetes y embarazadas. - Desplegar brigadas "barrido" para completar esquemas de vacunación regular en niños que no pudieron asistir a sus controles durante las inundaciones, previniendo brotes secundarios de sarampión, rubéola o polio.	

	- Implementar grupos de apoyo y primeros auxilios psicológicos en comunidades afectadas. - Realizar sesiones de descarga emocional y soporte psicológico obligatorio para el personal de salud: médicos, enfermeras y TAPS que estuvieron en primera línea, muchos de los cuales podrían ser víctimas del fenómeno simultáneamente. - Derivar a psiquiatría los casos con estrés postraumático severo, depresión reactiva o ideación suicida detectados durante las intervenciones en territorio. - Activar áreas de almacenamiento temporal en niveles elevados (segundos pisos o plataformas) para evitar que el agua de inundación entre en contacto con desechos infecciosos y cortopunzantes. - Usar soluciones de hipoclorito de calcio al 10% para inactivación biológica in situ de los residuos previa al sellado reforzado, en caso de que la empresa recolectora no pueda acceder a la unidad de salud. - Coordinar con los GAD municipales para el establecimiento de rutas prioritarias de emergencia y puntos de transferencia fuera de las zonas anegadas. - Activar inmediatamente el traslado de biológicos ante alertas de cortes eléctricos que superen la autonomía de los generadores locales. Los termos y cajas térmicas deben estar pre-validados con sus respectivos paquetes de frío. - Identificar establecimientos de salud "ancla" o convenios con empresas privadas (farmacéuticas/alimentarias) que posean cuartos fríos y plantas de emergencia de gran capacidad para el resguardo provincial del stock. - En unidades con conectividad, usar sensores de temperatura con alerta al celular para que el personal de enfermería actúe antes de que se pierda la temperatura de seguridad para los biológicos (+/- 2°C a +/- 8°C$). - Activar Posadas de Mujeres Embarazadas (PME), realizar el traslado preventivo (antes de la lluvia intensa) de mujeres en el tercer trimestre hacia casas de acogida o "posadas" cercanas a Hospitales Básicos o Generales con capacidad quirúrgica (Centro Obstétrico).	

	- Asegurar que las brigadas móviles cuenten con Kits de Salud Reproductiva de Emergencia para la atención de partos inminentes en condiciones de aislamiento y métodos anticonceptivos de emergencia para evitar embarazos no planificados post-desastre.	
Reorganización de los servicios de emergencia a nivel hospitalario	- Coordinar con las direcciones provinciales para disponer de talento humano que fortalezca la capacidad de atención de los servicios de emergencia de los hospitales básicos y generales. - Reorganizar internamente el talento humano de los establecimientos para cubrir la demanda de atención en el servicio de emergencia, de ser necesario. - Capacitar al personal de emergencia sobre la identificación adecuada riesgo de enfermedades propias de la época lluviosa; con énfasis en las enfermedades arbovirales, así como su terapéutica. - Identificar las necesidades de insumos, medicamentos y dispositivos. - Coordinar los préstamos de equipamiento biomédico para el servicio de emergencia. - Reorganizar internamente el equipamiento biomédico para cubrir la demanda de atención en el servicio de emergencia, de ser necesario. - Coordinar con las direcciones provinciales para la entrega, en calidad de préstamo, de equipamiento biomédicos que fortalezca la capacidad de atención de los servicios de emergencia de los hospitales básicos y generales.	Dirección Nacional de Hospitales
Disponibilidad operativa del servicio de salud móvil	- Implementar las directrices preventivas inmediatas en los establecimientos de salud. - El personal técnico desarrollará el recorrido general de verificación visual de la infraestructura de los hospitales móviles donde detecte posibles áreas o sistemas de ingeniería que podría ser afectadas (sumideros de pisos, terrazas, losas, canaletas, bajantes de agua lluvia, rejillas, etc) que no obstaculicen la evacuación de agua - Verificar las posibles filtraciones de agua, para corregir inmediatamente de hospitales móviles - Identificar posibles puntos de ingreso por desbordamiento de agua lluvia, colocar barreras artificiales temporales, con el criterio de no obstaculizar salidas	Dirección Nacional de Servicios de Atención de Salud Móvil

	de evacuación del personal y usuarios del hospital móvil. - Revisar el suministro de agua potable y energía eléctrica, para evitar cortes o contaminaciones que afecten el normal desenvolvimiento del hospital móvil. - Dar seguimiento monitoreo de unidades móviles de las actividades programadas para la atención en zona de afectación. - Establecer estrategias de transporte secundario con apoyo de otras ambulancias territorial (postas) - Coordinación interinstitucional del transporte sanitario aéreo con el apoyo de otras instituciones involucradas. - Garantizar la operatividad del servicio de atención prehospitalaria - Coordinar con otras instituciones que brinda el servicio transporte primario.	
Promoción de la salud y los determinantes	- Estructurar y oficializar material educomunicacional enmarcadas en temas de consejería nutricional, procesos de promoción de la salud sexual y salud reproductiva (con énfasis en asesoría en planificación familiar), violencia de género, interculturalidad, salud mental, agua de consumo humano, saneamiento e higiene. - Capacitar a funcionarios en la implementación de las acciones de promoción de la salud enmarcada en temas consejería nutricional, procesos de promoción de la salud sexual y reproductiva, salud mental, agua, saneamiento e higiene.	Subsecretaría de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad
	– Estructurar y capacitar en el uso de la herramienta de evaluación de condiciones de saneamiento en centros de alojamiento temporal. – Retroalimentar a los puntos focales de salud ambiental sobre los lineamientos a seguir en relación a la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU) que se encuentren durante las mingas comunitarias.	Dirección Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo
	– Promover la incorporación del enfoque intercultural y comunitario en la gestión de eventos adversos, fortaleciendo la comunicación de riesgo, la participación comunitaria, la articulación con actores de la medicina ancestral-tradicional y los sistemas comunitarios de cuidado, para garantizar una atención integral y culturalmente pertinente en los territorios afectados. – Realizar las adaptaciones de material educomunicacional con enfoque intercultural.	Dirección Nacional de Salud Intercultural y Equidad

	– Emitir directrices relacionadas a temáticas de alimentación y nutrición, para la planificación, composición, entrega y seguimiento de ayudas alimentarias dirigidas a población en situación de vulnerabilidad en el territorio ecuatoriano, garantizando criterios de calidad nutricional, pertinencia cultural, inocuidad alimentaria y sostenibilidad de la intervención. – Enviar el criterio técnico referente a la introducción de suplementos nutricionales preparados específicamente "Forzán", haciendo énfasis a la alimentación primeros mil días de vida, dado que constituyen una etapa crítica y determinante para el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños, por lo que las recomendaciones actuales establecen que la introducción de la alimentación complementaria debe realizarse a partir del sexto mes de vida, no antes ni de forma tardía. – Emitir directrices para realizar educación y consejería nutricional, utilizando las herramientas disponibles de alimentación y nutrición: Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador, para la población mayor de dos años de edad y las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios para los 1000 primeros días en Ecuador (GABSA). – Fortalecer las capacidades del personal de salud mediante procesos de capacitación en alimentación y nutrición en emergencias.	Dirección Nacional de Alimentación Saludable y Nutrición
	– Fortalecer las capacidades institucionales (puntos focales de participación social en salud) y comunitarias (representantes de Comités Ciudadanos de Salud, Vigilantes Comunitarios Voluntarios, Mesas Intersectoriales Parroquiales), mediante procesos de capacitación técnica, orientados a las acciones preventivas y de respuesta frente a la época lluviosa, con énfasis en el “Fenómeno de El Niño”. – Articular estrategias de comunicación con la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, para la difusión de material educomunicacional hacia los actores y organizaciones sociales, así como los representantes de los mecanismos y espacios de participación social en salud (Comités Ciudadanos de Salud,	Dirección Nacional de Participación Social en Salud

	Vigilantes Comunitarios Voluntarios, Mesas Intersectoriales Parroquiales). – Promover la revisión y/o actualización de los Planes Locales de Salud, mediante la emisión de directrices institucionales que permitan incorporar al "Fenómeno de El Niño" como parte del análisis de las determinantes sociales de salud (determinantes ambientales). – Fortalecer los mecanismos y espacios de participación social en salud, para la identificación, sistematización y análisis de las alertas presentadas por la comunidad, para una respuesta oportuna y articulada entre instancias del Ministerio de Salud Pública. – Fomentar la implementación de las mesas intersectoriales parroquiales con los actores locales e institucionales del territorio, como un espacio de deliberación interinstitucional, para la identificación oportuna de alertas y respuestas frente a las afectaciones por el "Fenómeno de El Niño".	
	– Socializar, implementar y ejecutar en el nivel desconcentrado las directrices e insumos técnicos priorizados, en el marco de las atribuciones, competencias y responsabilidades institucionales conferidas a esta Cartera de Estado en cumplimiento del marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos. En este contexto las acciones que se priorizan para este plan de contingencia son las siguientes: – Elaborar insumos técnicos para procesos en derechos humanos, género e inclusión en salud para el nivel desconcentrado. – Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación al personal de salud orientadas al fortalecimiento de la atención integral a grupos prioritarios y personas en situación de vulnerabilidad. – Brindar asistencia técnica al nivel desconcentrado para el acceso oportuno a la salud de las víctimas directas o indirectas identificadas en el marco de la emergencia.	Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión
	– Establecer líneas de acción de Promoción de la Salud en el marco de las competencias ante el Fenómeno de El Niño.	Dirección Nacional de Promoción de la Salud

	– Desarrollar materiales educomunicacionales y herramientas para el abordaje de líneas de acción de Promoción de la Salud a través de los niveles desconcentrados ante el Fenómeno de El Niño. – Emitir a los niveles desconcentrados las líneas de acción de Promoción de la Salud descripción en el presente documento. – Monitorear, evaluar y dar seguimiento a los pares de niveles desconcentrados para la adecuada implementación de líneas de acción de Promoción de la Salud conforme lo establecido en el presente documento.	
Exposición a amenazas y planificación de contingencia	- Generar el escenario de exposición de los establecimientos de salud frente a inundaciones y movimientos en masa. - Solicitar a las direcciones provinciales y establecimientos de salud la generación de planes de contingencia. - Actualizar de ser necesario, en coordinación con todas las dependencias, el plan de contingencia nacional frente a la época lluviosa – fenómeno de El Niño. - Activar la Mesa Técnica de Trabajo 2 Salud y Atención Prehospitalaria o la que haga de sus veces para establecer coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales.	Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Daños
Comunicación en riesgos	- Realizar campañas de sensibilización y comunicación sobre enfermedades vectoriales y enfermedades respiratorias relacionadas con la época lluviosa y el fenómeno de El Niño. - Realizar la difusión y réplica de mensajes educomunicacionales "Campaña de Difusión Control vectorial". - Agenda de medios sobre las acciones respuesta Fenómeno El Niño. - Apoyo en la implementación de mingas comunitarias - Capacitación en comunicación de riesgos a periodistas en el país. (virtual). - Cobertura periodística informativa para comunicar a la población sobre las acciones ejecutadas por parte del MSP y otras instituciones que participen del plan.	Dirección de Comunicación, Imagen y Prensa

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
Aprobado por:	**Álvaro Adrián Molina Galarraga** Viceministro de Gobernanza de la Salud	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ALVARO ADRIAN MOLINA GALARRAGA
Revisado por:	**Hugo Enrique Armendariz Pinos** Subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: HUGO ENRIQUE ARMENDARIZ PINOS
	Andrea Elizabeth Bravo Remache Subsecretaria de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ANDREA ELIZABETH BRAVO REMACHE
	Ruvi Paola Guzmán Naranjo Subsecretaria de Redes de Atención Integral de Primer Nivel, Encargada	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: RUVI PAOLA GUZMAN NARANJO
	Wendy Brasilia Gavica Vásquez Subsecretaria de Atención de Salud Móvil, Hospitalaria y Centros Especializados	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: WENDY BRASILIA GAVICA VASQUEZ
	María Cecilia Vargas Costales Subsecretaria de Gestión de Operaciones y Logística en Salud	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MARIA CECILIA VARGAS COSTALES
Actualizado por:	**Joseph Jerónimo Alvarado Alay** Director Nacional de Abastecimiento de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Otros Bienes Estratégicos en Salud	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSEPH JERONIMO ALVARADO ALAY
	Glenda María Gutiérrez Carrión Directora Nacional de Atención Integral en Salud	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: GLENDA MARIA GUTIERREZ CARRION
	Pedro Felipe Espinoza Guerrero Director de Comunicación, Imagen y Prensa	Pedro Felipe Espinoza Guerrero Time Stamping Security Data
	Ana Judith Sánchez Directora Nacional de Estrategias de Prevención y Control Para Enfermedades Transmisibles, Encargada	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ANA JUDITH SANCHEZ PIÑUELA
	Christian Roberto Arias Vivero Director Nacional de Gestión de Riesgos y Daños	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN ROBERTO ARIAS VIVERO
	Alejandro Vladimir Díaz Sorto Director Nacional de Hospitales, Encargado	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ALEJANDRO VLADIMIR DIAZ SORTO

	Ruth Susana Tapia Ortega Director Nacional de Infraestructura Sanitaria	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: RUTH SUSANA TAPIA ORTEGA
	Carlos Alberto Pillajo Villacreses Director Nacional de Servicios de Atención de Salud Móvil	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO PILLAJO VILLACRESES
	Mauro Antonio Andrade Viteri Director Nacional de Promoción de la Salud	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MAURO ANTONIO ANDRADE VITERI
	Edwin Edgar Morocho Aguagallo Director Nacional de Salud Intercultural y Equidad	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDWIN EDGAR MOROCHO AGUAGALLO
	Adrián Joshua Mora Yerovi Director Nacional de Derechos Humanos, Genero e Inclusión	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ADRIAN JOSHUA MORA YEROVI
	Mayra Elizabeth Caguano Galarza Directora Nacional de Alimentación Saludable y Nutrición, Encargada	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MAYRA ELIZABETH CAGUANO GALARZA
	Edwin Rogelio Echeverría Morales Director Nacional de Participación Social en Salud	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDWIN ROGELIO ECHEVERRIA MORALES
	Nicolás Corral Bustamante Director Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: NICOLAS CORRAL BUSTAMANTE
	Christian Santiago Trujillo Hernández Director Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Encargado	Christian Santiago Trujillo Hernandez Time Stamping Security Data